Perfil V3 · código por código

Diabetes y Nutrición

Los 68 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Diabetes y Nutrición, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 19 códigos

1.02.1.001 Desnutrición

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor, alcohólico, enfermo crónico u hospitalizado: baja de peso involuntaria ≥4,5 kg o ≥5 % en un año, IMC bajo, sarcopenia y debilidad.
- Confirmar con evaluación nutricional: antropometría (IMC, circunferencia de pantorrilla), MNA (<17 desnutrición, 17–23,5 riesgo) y laboratorio (albúmina, prealbúmina, linfocitos).
- Buscar la causa: ingesta insuficiente (pobreza, depresión, demencia, dentadura), malabsorción, cáncer, ERC, hipertiroidismo, fármacos.
- Manejo inicial: aporte proteico 1,2–1,5 g/kg/día repartido en las comidas, suplementos orales, vitamina D si está baja y ejercicio de fuerza.
- En desnutrición severa realimentar de forma gradual (riesgo de síndrome de realimentación: hipofosfemia, hipokalemia) y dar tiamina antes de la glucosa.
- Seguimiento: derivar a nutricionista/equipo especializado; control de peso seriado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un hombre de 80 años, que vive solo, ha bajado 8 kg en 4 meses (de 64 a 56 kg). Come una vez al día, tiene la prótesis dental en mal estado y menor fuerza de prensión. Su IMC actual es 19 kg/m² y la albúmina es 3,1 g/dL. La evaluación inicial no muestra signos de cáncer. **¿Cuál es el diagnóstico nutricional más adecuado?**
>
> **A)** Estado nutricional normal, porque el IMC es mayor de 18,5
> **B)** Sobrepeso
> **C)** Obesidad sarcopénica
> **D)** Desnutrición proteico-calórica, por pérdida de peso significativa
> **E)** Caquexia neoplásica confirmada
>
> Respuesta D. Una pérdida mayor al 5% en 3 meses o al 10% en 6 meses es significativa: él perdió 12,5% en 4 meses. En el adulto mayor un IMC bajo 23 ya se considera enflaquecido. Se suman baja ingesta, problemas dentales, aislamiento y menor fuerza: desnutrición, con manejo multidimensional y social.

1.02.1.002 Diabetes gestacional

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) · Tema 2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje: glicemia de ayuno a toda embarazada al ingreso y PTGO 75 g universal a las 24–28 semanas (repetir a las 32–34 si hay feto grande, polihidramnios o DMG previa).
- Diagnóstico: dos glicemias de ayuno ≥100 mg/dL en días distintos, o PTGO con basal ≥100 o 2 h ≥140 mg/dL (basta un valor). En el embarazo no existe la prediabetes.
- Ayuno 100–125 al ingreso: repetir de inmediato (no pedir PTGO); si vuelve ≥100 es DMG. Si ≥126 antes de las 12 semanas: diabetes pregestacional.
- Tratamiento inicial: terapia nutricional fraccionada (4 comidas + 2–3 colaciones, nunca <1.500 kcal) con automonitoreo 4–6 veces/día por 1–2 semanas; metas: ayuno 70–90/95, 1 h <140, 2 h <120 mg/dL.
- Iniciar insulina (NPH nocturna si falla el ayuno, rápida precomida si falla el postprandial) si >20 % de valores fuera de meta o CA fetal ≥p75–90. Glibenclamida contraindicada.
- Riesgo: macrosomía, polihidramnios, distocia de hombros, hipoglicemia neonatal. Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico; PTGO a las 6–12 semanas posparto.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 44

Una paciente de 30 años, acude a su primer control de un embarazo de 10 semanas. Sus partos anteriores fueron eutócicos, con recién nacidos de término de 4 kilogramos. Entre sus exámenes de control trae un Elisa VIH que resultó negativo, hematocrito de 38%, glicemia de ayuno de 112 mg/dL y urocultivo negativo. Su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
B) Iniciar metformina oral
C) Repetir glicemia de ayuno
D) Repetir el urocultivo
E) Mantener el control embarazo normal

Respuesta C. Glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL en el embarazo: sospecha de diabetes gestacional, que se confirma repitiendo la glicemia de ayuno. La PTGO sería la conducta en una mujer no embarazada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 133

Una paciente de 36 años, cursando su primer embarazo a las 28 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que arroja una glicemia basal de 98 mg/dl y una glicemia postcarga, a las 2 horas, de 147 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Resistencia a la insulina
B) Diabetes mellitus gestacional
C) Diabetes mellitus pregestacional
D) Intolerancia a la glucosa oral
E) Embarazo normal

Respuesta B. PTGO a las 2 horas ≥ 140 mg/dL en una embarazada: diabetes gestacional. Basta un valor alterado aunque la basal sea normal. La intolerancia a la glucosa no existe en el embarazo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 81

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y glicemia poscarga de 139 mg/dl. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir la prueba de tolerancia a la glucosa a las 32 semanas
B) Iniciar metformina
C) Iniciar dieta hipoglucídica
D) Iniciar insulina
E) Mantener el control normal del embarazo

Respuesta E. Basal < 100 y postcarga < 140 mg/dL: PTGO normal. Sin factores de alto riesgo (feto grande, polihidramnios, DMG previa) no se repite a las 32–34 semanas: control normal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 133

Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 205 a las 2 horas. **Además de dieta y ejercicio, el tratamiento de elección es:**

A) Acarbosa
B) Sitaglipina
C) Metformina
D) Insulina
E) Glibenclamida

Respuesta D. Diabetes gestacional: primero terapia nutricional y, si no se logran las metas, insulina, que es el fármaco de elección en el embarazo.

Pregunta de práctica

Primigesta de 26 años, embarazo de 10 semanas, asintomática. En sus exámenes de ingreso tiene glicemia de ayuno de 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayuno estricto: 106 mg/dL. Sin glucosuria ni antecedentes familiares de diabetes. **¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**

A) Glicemia de ayuno alterada
B) Diabetes mellitus gestacional
C) Diabetes mellitus pregestacional
D) Embarazo normal; solicitar PTGO a las 24–28 semanas
E) Intolerancia a la glucosa del embarazo

Respuesta B. En el embarazo no existe la glicemia de ayuno alterada. Dos glicemias de ayuno ≥ 100 mg/dL y < 126 mg/dL: diabetes gestacional. No es pregestacional porque para eso se necesitan valores de no embarazada (≥ 126 mg/dL). Se deriva a alto riesgo obstétrico y se inicia plan de alimentación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

paciente con diabetes gestacional 28 semanas, con tto metformina pero con cifras elevadas de glicemia, se preguntaba cómo continuar tto

A) Pioglitazona
B) agregar insulina
C) Glibenclamida
D) Sitagliptina
E) Metformina

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Pioglitazona). agregar insulina. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (agregar insulina, Glibenclamida) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pacient

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 108 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada 24 semanas con glicemia post 75gr de glucosa en 200 ¿Cual es el manejo?

A) Iniciar insulina
B) Metformina
C) Glibenclamida
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar insulina (opción A). Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 22 años, acude a su primer control de un embarazo de 8 semanas. Entre sus exámenes trae un VDRL que resultó negativo, hematocrito de 39% y glicemia de ayuno de 112 mg/dL. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecua- da?

A) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
B) Iniciar hipoglicemiantes orales
C) Repetir glicemia de ayuno
D) Solicitar insulinemia basal
E) Mantener el control embarazo normal

Respuesta C. Tiene una glicemia de ayuno mayor o igual 100, lo que en el embarazo, obliga a re- petir la glicemia de ayuno.

1.02.1.003 Diabetes mellitus pregestacional

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) · Tema 2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

QUÉ HAY QUE SABER

- Diabetes previa al embarazo, o criterios de no embarazada antes de las 12 semanas (ayuno ≥126 mg/dL dos veces o glicemia ≥200 con síntomas).
- Riesgo propio: malformaciones por hiperglicemia en la organogénesis (cardíacas, regresión caudal), aborto, RCIU y muerte in utero, además de macrosomía.
- Planificación preconcepcional: HbA1c lo más cercana a la normalidad (<6,5 %) antes de embarazarse, ácido fólico, suspender IECA/ARA-II y estatinas, fondo de ojo y función renal.
- Tratamiento de elección: insulina (NPH + cristalina o análogos); metas estrictas ayuno 70–95 y 1 h postprandial <140 mg/dL, sin hipoglicemias. No usar sulfonilureas.
- Seguimiento: control conjunto con alto riesgo obstétrico; fondo de ojo por trimestre, función renal y albuminuria, ecografía morfológica y ecocardiografía fetal.
- Posparto: mantiene su tratamiento previo (la insulina baja rápido al salir la placenta); fomentar lactancia y anticoncepción planificada.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 176

Una mujer cursa un embarazo de 10 semanas y se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 128 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Prediabetes
B) Diabetes mellitus gestacional
C) Glicemia de ayuno alterado
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Intolerancia a la glucosa oral

Respuesta D. Glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL antes de las 12 semanas: sospecha de diabetes pregestacional (se confirma con una segunda glicemia ≥ 126 mg/dL). Prediabetes, GAA e ITG no existen en el embarazo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 107

Una paciente embarazada de 10 semanas se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glicemia normal para el embarazo
B) Intolerancia a la glucosa oral
C) Diabetes mellitus gestacional
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Resistencia a la insulina

Respuesta D. Una glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL al inicio del embarazo hace sospechar una diabetes pregestacional, que se confirma con una segunda glicemia ≥ 126 mg/dL. Si los valores estuvieran entre 100 y 125 mg/dL sería diabetes gestacional.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente embarazada de 9 semanas, se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glicemia normal para el embarazo
B) Intolerancia a la glucosa
C) Diabetes mellitus gestacional
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Prediabetes

Respuesta D. Es una mala pregunta, porque solo dan 1 glicemia, lo que no diagnostica nada. Sin embargo, se considera diabetes pregestacional que haya 2 glicemias de ayuno mayores o iguales a 126, a inicio del embarazo. Así mismo, se considera diabetes gestacional, si las dos glicemias son mayores o iguales a 100, pero menores a 126.

1.02.1.004 Diabetes Mellitus tipo 1

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY · Tema 3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio · Tema 3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit absoluto de insulina por destrucción autoinmune de la célula beta (5–10 % de los diabéticos). Niño, adolescente o adulto joven normo o bajo peso.
- Debut agudo y catabólico: poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso marcada; 25–30 % debuta con cetoacidosis.
- Confirmar con criterios de diabetes; si hay duda, péptido C bajo o indetectable y anticuerpos positivos (anti-GAD65, anti-IA2, IAA, ZnT8). LADA: adulto con otra autoinmunidad y falla precoz a orales.
- Tratamiento inicial: insulina obligatoria (no responde a orales); esquema basal-bolo desde el inicio. Descartar y tratar cetoacidosis si hay vómitos, dolor abdominal o Kussmaul.
- Es patología GES: derivar a endocrinología/diabetología para educación, insulinoterapia intensificada y automonitoreo.
- Tamizaje de complicaciones desde el 5.º año del debut: RAC, fondo de ojo y examen de pies anual; buscar otras autoinmunidades (tiroides, celiaquía).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 113

Una paciente de 36 años, hipotiroidea y con antecedente de vitíligo fue diagnosticada de diabetes hace un año. Está en tratamiento con 2 gramos de metforminal al día y 20 mg de glibenclamida al día, más dieta. Su hemoglobina glicosilada es de 8,5% y su glicemia de ayuno resulta 196 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Diabetes mellitus 1 - LADA
B) Diabetes mellitus Mody
C) Diabetes mellitus secundaria
D) Diabetes mellitus 2 con tendencia a la cetosis
E) Diabetes mellitus controlada

Respuesta A. Autoinmunidad asociada (hipotiroidismo y vitíligo) más mal control pese a dosis altas de metformina y glibenclamida: diabetes LADA, la autoinmune del adulto, que se trata con insulina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 17

Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
B) Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas
C) Agregar insulina NPH nocturna
D) Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
E) Agregar metformina al tratamiento

Respuesta B. La DM1 se trata con esquema intensificado basal-bolo. Una sola NPH matinal hace su peak antes del almuerzo (hipoglicemia) y se agota en la noche (ayuno alto). Dos NPH más tres bolos de cristalina es un basal-bolo aceptable.

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años con tiroiditis de Hashimoto en tratamiento con levotiroxina, IMC 21,5 kg/m². Consulta por polidipsia, astenia y baja de 4 kg en 2 meses. Glicemia de ayuno 285 mg/dL, HbA1c 10,2 %, sin cetonuria. Se inició metformina, sin descenso glicémico tras 4 semanas de escalamiento. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Agregar glibenclamida y controlar en 3 meses
B) Solicitar anti-GAD65 y péptido C, e iniciar insulina
C) Solicitar estudio genético para MODY
D) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral
E) Aumentar la metformina a dosis máxima

Respuesta B. Adulta joven, delgada, con autoinmunidad previa (Hashimoto), hiperglicemia sintomática y falla a metformina: LADA. Se piden anti-GAD65 y péptido C y se inicia insulina de inmediato para frenar el catabolismo. Sumar orales solo retrasa el tratamiento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 34 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo desde la adolescencia, vitíligo y diabetes diagnosticada hace un año, en tratamiento con régimen oral, acude a control con glicemia de ayuno en 250 mg/dL y hemoglobina glicosilada en 9,0%. El diagnóstico más probable es:

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2
C) Diabetes mellitus autoinmune
D) Hipopituitarismo autoinmune
E) Neoplasia endocrina múltiple tipo 1

Respuesta C. El diagnóstico es una diabetes LADA, que si bien es igual a la DM1, tiene un nombre distinto. Orientan el vitíligo, el hipotiroidismo (autoinmunes ambos) y la falta de respuesta.

1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY · Tema 1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS · Tema 1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas · Tema 2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL · Tema 2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas · Tema 2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 · Tema 3.1 Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio · Tema 3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis · Tema 3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: glicemia de ayuno ≥126 mg/dL (2 veces), PTGO 2 h ≥200, HbA1c ≥6,5 % (confirmar en asintomático) o glicemia al azar ≥200 con síntomas (no se repite). Ayuno 100–125: PTGO.
- GES en ≥15 años: confirmación en 45 días y tratamiento en 24 horas. Desde el inicio: estilo de vida (baja de 5–10 % del peso, 150 min/semana de ejercicio) + metformina 500–850 mg titulando hasta 1.700–2.550 mg/día.
- Meta HbA1c <7 % (joven sin riesgo <6,5 %; adulto mayor activo <7,5 %; frágil <8–8,5 %). Control a los 3 meses: si está sobre la meta con dosis plena, agregar 2.º fármaco (glibenclamida en APS; iSGLT2 si IC o ERC; GLP-1 si enfermedad aterosclerótica).
- Insulina NPH nocturna 10 UI o 0,1–0,2 UI/kg + metformina si HbA1c ≥9–10 %, glicemia >250–300, catabolismo, cetonuria o falla de biterapia; titular +2 UI (ayuno 131–180) o +4 UI (>180) cada 3–7 días.
- Metformina: ajustar a VFG (30–44: máx. 1.000 mg; <30: suspender). Glibenclamida: evitar en adulto mayor y nefrópata por hipoglicemia prolongada.
- Seguimiento completo en APS (PSCV): HbA1c cada 3–6 meses, PA <130/80, LDL <70, RAC y fondo de ojo anual desde el diagnóstico, monofilamento anual.

PREGUNTAS (17)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 114

Un paciente de 32 años, normopeso, diagnosticado de diabetes desde los 20 años, en tratamiento. Su padre, su hermano y su abuelo son diabéticos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) DM tipo 1
B) DM tipo 2
C) DM LADA
D) DM Mody
E) DM mitocondrial

Respuesta D. Diabetes diagnosticada antes de los 25 años en un paciente normopeso, con tres generaciones afectadas (abuelo, padre, hermano): herencia autosómica dominante, típica de la MODY. La LADA es autoinmune y no se repite así en la familia; la mitocondrial se hereda por vía materna.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 33

Un paciente de 17 años, obeso, se realiza chequeo con glicemia de ayuno que resulta en 130, por lo que se repite este examen obteniendo 137, no ha presentado síntomas. En el examen físico destaca presencia de acantosis nígricans en pliegue cervical y acrocordones. **El diagnóstico más probable es:**

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2
C) Diabetes mellitus autoinmune
D) Intolerancia a la glucosa
E) Glicemia de ayuno alterada

Respuesta B. Dos glicemias de ayuno ≥ 126 mg/dL confirman diabetes. En un adolescente obeso, asintomático y con acantosis nigricans y acrocordones (resistencia a la insulina), el tipo más probable es la DM2, pese a la edad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 24

Un paciente de 81 años, con antecedente de diabetes, en tratamiento con metformina 850 al día, se realiza exámenes de control, entre los que destaca una hemoglobina A1c de 7,5%. **La conducta más adecuada es:**

A) Mantener el tratamiento
B) Agregar glibenclamida
C) Subir la dosis de metformina
D) Agregar insulina
E) Agregar sitagliptina

Respuesta A. En el adulto mayor la meta de HbA1c se flexibiliza (bajo 7,5–8 %). Con 7,5 % está en meta: se mantiene el tratamiento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 105

Un paciente de 59 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850mg dos veces al día y glibenclamida 5mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la glibenclamida
B) Aumentar dosis de glibenclamida
C) Suspender metformina
D) Aumentar dosis de metformina
E) Mantener el tratamiento sin cambios

Respuesta E. Adulto de 59 años con HbA1c bajo 7 %, función renal normal y sin hipoglicemias: está en meta, no se modifica el tratamiento.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 118

Un paciente de 85 años, con antecedente de deterioro funcional y cognitivo inicial y diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg dos veces al día y glibenclamida 5 mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la glibenclamida
B) Disminuir la dosis de glibenclamida a 5 mg una vez al día
C) Suspender metformina
D) Disminuir dosis de metformina
E) Mantener el tratamiento sin cambios

Respuesta A. Adulto mayor frágil (85 años, deterioro funcional y cognitivo): meta de HbA1c bajo 8–8,5 %. Con 6,9 % está sobretratado y en riesgo de hipoglicemia; se suspende la glibenclamida, la sulfonilurea que la produce, y se mantiene la metformina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 132

Un paciente de 45 años se realiza glicemias de ayuno que resultan 128 y 136 mg/dl. Se solicita hemoglobina glicosilada, que resulta 7,2%. **¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?**

A) Glibenclamida
B) Metformina
C) Pioglitazona
D) Sitagliptina
E) Repaglinida

Respuesta B. Tiene diagnóstico de diabetes (dos glicemias de ayuno ≥ 126 mg/dL). Por la edad y la ausencia de otros antecedentes, lo más probable es que sea tipo 2. Sin indicaciones de insulina, se inicia metformina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 17

Un hombre de 33 años, obeso, consulta por polidipsia y baja de peso de 6 kilogramos, en los últimos dos meses. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes, entre los que destacan glicemia de ayuno de 245 mg/dl y hemoglobina glicosilada: 9,2%. **El tratamiento inicial más adecuado es:**

A) Metformina
B) Sitagliptina
C) Insulina
D) Liraglutide
E) Glibenclamida

Respuesta C. Tanto por los síntomas de diabetes (baja de peso y polidipsia) como por la HbA1c mayor a 9%, está indicada la insulina.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 151

Diabético en tratamiento con metformina, Hb1Ac >9%. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Agregar glibenclamida 5 mg/día
B) Agregar sitagliptina 100 mg/día
C) Agregar liraglutida 1,2 mg SC
D) Aumentar metformina al máximo
E) Insulina NPH

Respuesta E. Con metformina y HbA1c sobre 9%, ningún segundo fármaco oral o GLP-1 alcanza a bajarla a la meta: está indicada la insulina NPH, manteniendo la metformina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 125

Un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2000mg al día, glibenclamida 15mg al día y enalapril 20mg al día, acude a control con exámenes, donde destaca glicemia de ayuno de 180mg/dL y hemoglobina glicosilada de 8,8%. Se ha mantenido sin síntomas y su examen físico es normal. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Aumentar dosis de glibenclamida
B) Aumentar dosis de metformina
C) Iniciar insulina
D) Reemplazar metformina con rosiglitazona
E) Reemplazar glibenclamida con sitagliptina

Respuesta C. Ya está en biterapia con dosis altas de metformina y glibenclamida. Subir un poco más los orales tendría poco efecto para una HbA1c de 8,8%: la falla de la biterapia oral indica iniciar insulina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 141

Un paciente con antecedente de una angioplastia coronaria hace 6 meses, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2 gramos al día, presenta HbA1c de 8,2% y glicemia de ayuno de 180 mg/dl. **¿Cuál es el tratamiento más adecuada?**

A) Agregar glibenclamida
B) Iniciar empaglifozina
C) Iniciar saxagliptina
D) Agregar insulina NPH nocturna
E) Iniciar pioglitazona

Respuesta B. Con enfermedad coronaria establecida, los fármacos de elección para agregar a la metformina son los que reducen eventos cardiovasculares: iSGLT2 como la empagliflozina, o agonistas GLP-1.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 107

Un paciente de 72 años, con antecedente de un infarto miocárdico, hace 2 meses. Durante la hospitalización, se diagnosticó diabetes mellitus, iniciándose metformina 850 mg cada 12 horas. Sin embargo, desde entonces ha presentado diarrea. Sus glicemias de ayuno son cercanas a 140 mg/dl y su hemoglobina glicosilada resulta 8,2%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reemplazar la metformina por glibenclamida
B) Agregar insulina NPH
C) Reemplazar el tratamiento por metformina 750 mg XR
D) Reemplazar la metformina por sitagliptina
E) Aumentar la dosis de metformina

Respuesta D. La metformina le produce efectos adversos, por lo que se suspende. En un adulto mayor con infarto reciente, se prefiere la sitagliptina sobre la glibenclamida por su seguridad (sin hipoglicemia). No tiene indicaciones de insulina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 149

Un paciente de 82 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y dieta, acude a control, con glicemia de ayuno de 355 mg/dl, hemoglobina glicosilada de 9,5%. **¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su diabetes?**

A) Agregar glibenclamida
B) Agregar sitagliptina
C) Inicial insulina NPH
D) Iniciar insulina glargina
E) Iniciar liraglutide

Respuesta C. Glicemia de ayuno > 300 mg/dL y HbA1c > 9 %: indicación de insulina. La insulina basal de inicio en atención primaria es la NPH al acostarse, manteniendo la metformina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 161

Paciente de 65 años con DM2 en tratamiento con insulina NPH nocturna. Presenta hiperglicemias en ayuno de 200-240 mg/dL. Glicemias a las 3 AM: 65 mg/dL. **¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A) Agregar glibenclamida
B) Agregar sitagliptina
C) Agregar pioglitazona
D) Reducir dosis de insulina NPH nocturna
E) Cambiar a insulina basada en metformina

Respuesta D. Efecto Somogyi: hipoglicemia a las 3 AM seguida de hiperglicemia de rebote en ayuno. La solución es REDUCIR la NPH nocturna, no aumentarla.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 158

Mujer asintomática de 46 años de edad, con IMC de 24. Tiene antecedente de diabetes gestacional con su último embarazo. Se practica una glicemia en ayunas que resulta en 112 mg/dl. **La conducta más adecuada es:**

A) Repetir la glicemia en ayunas
B) Practicar niveles de hemoglobina glicosilada
C) Indicar metformina
D) Realizar control de glicemia en 6 meses
E) Solicitar curva de tolerancia a la glucosa

Respuesta E. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL en una mujer no embarazada: glicemia de ayuno alterada. La conducta es la PTGO con 75 g; repetir la glicemia de ayuno no aporta.

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años con DM2 de 8 años, con metformina 850 mg c/8 h y glibenclamida 10 mg c/12 h, adherencia confirmada. Consulta por astenia, baja de 5 kg en 2 meses y nicturia. IMC 27, PA 130/80. Glicemia de ayuno 264 mg/dL, HbA1c 10,4 %, creatinina 0,9 mg/dL, orina sin cetonas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Agregar sitagliptina y controlar en 3 meses
B) Iniciar NPH al acostarse, manteniendo la metformina
C) Aumentar la glibenclamida a dosis máxima
D) Suspender los orales e iniciar insulina cristalina endovenosa
E) Iniciar NPH con la cena y suspender la metformina

Respuesta B. Falla secundaria a biterapia oral a dosis plenas, con HbA1c > 10 % y síntomas catabólicos: se inicia insulina basal, NPH al acostarse (10 UI o 0,1–0,2 UI/kg), manteniendo la metformina. La NPH con la cena produce hipoglicemia nocturna; la vía endovenosa es para el paciente hospitalizado grave.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 162 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 45 años, presenta polidipsia y poliuria de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 4 kilogramos en un mes. Al examen físico, se observa obeso con IMC: 35 y con presencia de acantosis nigricans en el cuello, sin otras alteraciones. Se solicita glicemia de ayuno, que resulta 318 mg/dl.

A) Iniciar dieta y metformina
B) Iniciar dieta y controlar
C) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
D) Repetir la glicemia de ayuno
E) Iniciar insulina

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Iniciar dieta y metformina). El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se basa en un enfoque escalonado que comienza siempre con cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio) más metformina como fármaco de primera línea. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con polidipsia, poliuria, baja de peso y glicemia >300 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Metformina 850 mg cada 12 horas
B) Iniciar insulina
C) Empagliflozina 10 mg/día
D) Liraglutida 0,6 mg subcutáneo
E) Sitagliptina 100 mg/día

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar insulina (opción B). Iniciar insulina. Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

1.02.1.006 Diabetes por corticoides

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperglicemia inducida por glucocorticoides (también tacrolimus, antipsicóticos atípicos); predomina la hiperglicemia vespertina/postprandial con ayuno casi normal.
- Sospechar en paciente con corticoides sistémicos y glicemias >140 mg/dL; en el hospitalizado la HbA1c ≥6,5 % indica que ya era diabético.
- Monitorizar con glicemia capilar antes de almuerzo y cena, no solo en ayunas.
- Tratamiento inicial: insulina programada (NPH matinal junto con la prednisona, ajustada a la dosis del corticoide) más corrección; nunca esquema móvil aislado. Meta hospitalaria 140–180 mg/dL.
- Al reducir el corticoide, bajar la insulina en la misma proporción para evitar hipoglicemias.
- Seguimiento: derivar si persiste hiperglicemia tras suspender el corticoide; reevaluar con HbA1c o glicemia de ayuno.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 93

Un paciente de 35 años, con antecedente de obesidad y resistencia a la insulina, presenta una reacción alérgica severa relacionada con el uso de fármacos, por lo que es hospitalizado para manejo con soporte y corticoides sistémicos. Durante su hospitalización se realizan exámenes entre los que destaca glicemia de 180 mg/dL, que se mantiene en rangos similares en varias tomas. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A) Péptido C
B) Test de tolerancia a la glucosa oral
C) Hemoglobina glicosilada
D) Índice de HOMA
E) Insulinemia postcarga de glucosa

Respuesta C. Con un descompensante agudo (reacción alérgica grave, corticoides) la glicemia y la PTGO salen alteradas por el estrés. La HbA1c refleja los 2–3 meses previos y es el examen de elección: ≥ 6,5 % confirma diabetes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 24

Mujer de 55 años con DM2 en tratamiento con metformina, requiere corticoterapia con prednisona 40 mg/día por enfermedad pulmonar. Sus glicemias de ayuno eran 130 mg/dL y post-prandiales suben a 280 mg/dL. **¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A) Iniciar insulina
B) Agregar metformina adicional
C) Pioglitazona
D) Glibenclamida
E) Sitagliptina

Respuesta A. Los corticoides en dosis altas son una de las indicaciones de insulinoterapia: permiten ajustar rápido y con flexibilidad. Los hipoglicemiantes orales no logran el control necesario.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 169

Paciente hospitalizada con hidrocortisona endovenosa y glicemias elevadas persistentes. **¿Cuál es el examen para el diagnóstico?**

A) Glicemia en ayunas
B) Test de tolerancia oral a la glucosa
C) Insulinemia basal
D) Hemoglobina glicosilada (HbA1c)
E) Péptido C

Respuesta D. La hiperglicemia hospitalaria se define con o sin diabetes previa. Con corticoides y estrés agudo, la glicemia no sirve para diagnosticar diabetes de base; la HbA1c refleja los últimos 2 a 3 meses y, si es ≥ 6,5%, certifica que la paciente ya era diabética antes del ingreso.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 24

Mujer de 55 años con DM2 en tratamiento con metformina requiere corticoterapia con prednisona 40 mg/día por una enfermedad pulmonar. Sus glicemias de ayuno son de 130 mg/dL y las postprandiales suben a 280 mg/dL. **¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A) Iniciar insulina
B) Agregar metformina adicional
C) Pioglitazona
D) Glibenclamida
E) Sitagliptina

Respuesta A. Los corticoides producen hiperglicemia de predominio postprandial y vespertino por resistencia a la insulina. Con prednisona en dosis altas y glicemias de 280 mg/dL, la insulina (típicamente NPH matinal ajustada a la dosis del corticoide) es de elección por rapidez y flexibilidad. Los orales no logran control suficiente y la glibenclamida arriesga hipoglicemia nocturna.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 106 · texto original del banco, sin revisar

Asmática con crisis tratada con corticoides VO por 5 días, al 5to día se le solicita seguimiento con exámenes, presenta glicemia 130. Cuál es la conducta más apropiada

A) Repetir glicemia en 1 semana
B) Pedir hemoglobina glicosilada
C) Solicitar PTGO
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Pedir hemoglobina glicosilada (opción B). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

1.02.1.007 Dislipidemias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas · Tema 5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero estimar el riesgo cardiovascular, luego fijar la meta de c-LDL: muy alto (evento ateroesclerótico, DM con daño de órgano, VFG <45) <55–70 mg/dL; alto <70; moderado <100; bajo: estilo de vida.
- Calcular LDL con Friedewald (CT – HDL – TG/5) si TG <400. La meta es el LDL, no el colesterol total.
- Estatina según intensidad: alta (atorvastatina 40–80, rosuvastatina 20–40 mg; baja LDL ≥50 %) en riesgo muy alto y post SCA; moderada (atorvastatina 10–20, rosuvastatina 5–10). Sin meta con dosis máxima: + ezetimiba 10 mg.
- Mialgias con estatina: medir CK; normal = mialgia simple; 3–10 veces = miositis, suspender; >10 veces = rabdomiólisis.
- TG ≥500 mg/dL: prioridad prevenir pancreatitis con fenofibrato, cero alcohol y dieta pobre en grasas. Nunca gemfibrozilo con estatina.
- Hipercolesterolemia familiar: LDL ≥190 con TG normales, xantomas tendinosos, IAM familiar precoz; estatina máxima + ezetimiba. Seguimiento: perfil lipídico y transaminasas en PSCV.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 89

Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 3 meses, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9 mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos: 250 mg/dL, colesterol total: 253 mg/dL, HDL: 51 mg/dL, LDL: 152 mg/dL. No presenta síntomas. **El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:**

A) Fibratos
B) Estatinas
C) Dieta baja en ácidos grasos saturados
D) Ácido nicotínico
E) Ezetimibe

Respuesta B. Diabético de corta evolución: al menos riesgo moderado, con meta de c-LDL menor de 100 mg/dL. Un LDL de 152 está fuera de meta y los triglicéridos están bajo 500: la prioridad es el LDL y se indican estatinas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 41

Un paciente dislipidémico, está en tratamiento con atorvastatina 10 mg/día y se realiza un perfil lipídico de control con colesterol total: 183 mg/dl, colesterol HDL: 32 triglicéridos: 860 mg/dl. **¿Cuál es la dosis más adecuada?**

A) Subir la dosis de la atorvastatina a 40 mg/día
B) Cambiar la atorvastatina por rosivastatina
C) Agregar gemfobrozilo 900 mg/día
D) Agregar ezetimibe al tratamiento
E) Reemplazar la atorvastatina por gemfibrozilo 900 mg/día

Respuesta E. Con triglicéridos sobre 500 mg/dL la prioridad es prevenir la pancreatitis con un fibrato. El gemfibrozilo no se combina con estatinas por el riesgo de rabdomiólisis, por eso se reemplaza la estatina en vez de agregarlo.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 152

Diabético con HbA1c en buen rango, LDL 135 mg/dL y TG 330 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Fenofibrato
B) Gemfibrozilo
C) Atorvastatina
D) Omega-3 en dosis farmacológica
E) Ezetimibe

Respuesta C. Triglicéridos bajo 500 mg/dL: la prioridad es el LDL. En un diabético con LDL de 135 (meta bajo 100 o menos), el tratamiento inicial es una estatina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 134

Un paciente de 35 años, en tratamiento con atorvastatina, por hipercolesterolemia y cuyo padre tuvo un infarto a los 40 años, presentó mialgias y artralgias, por lo que decidió suspender el medicamento, sin indicación médica. Se controla con exámenes, entre los que destaca colesterol total: 354 mg/dl, colesterol LDL: 244 mg/dl, colesterol HDL: 70 mg/dl, triglicéridos: 198 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 254 UI/L. **El tratamiento más adecuado es:**

A) Colestiramina
B) Dieta estricta
C) Rosuvastatina
D) Ezetimibe
E) Fenofibrato

Respuesta C. LDL de 244 con padre infartado a los 40 años: perfil de hipercolesterolemia familiar, que necesita estatina. Con mialgias y CK prácticamente normal, se cambia a otra estatina como rosuvastatina en vez de abandonar el tratamiento. Los demás fármacos no bastan para un LDL tan alto.

Pregunta de práctica

Hombre de 34 años consulta por nódulos indoloros y firmes en la cara posterior de ambos tobillos, sobre los tendones de Aquiles. Su padre falleció de un IAM a los 41 años. Perfil lipídico: colesterol total 340 mg/dL, HDL 48 mg/dL, triglicéridos 130 mg/dL, LDL 266 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipercolesterolemia familiar heterocigota
B) Hipertrigliceridemia familiar aislada
C) Disbetalipoproteinemia familiar tipo III
D) Hiperlipidemia familiar combinada
E) Xantomatosis cerebrotendinosa recesiva

Respuesta A. LDL muy elevado (más de 190 mg/dL) con triglicéridos normales, xantomas tendinosos en el Aquiles (patognomónicos) y un familiar de primer grado con enfermedad coronaria precoz: hipercolesterolemia familiar heterocigota, autosómica dominante, por mutación del receptor de LDL.

1.02.1.008 Hipertensión arterial en diabetes tipo 2

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Meta PA <130/80 mmHg en el diabético (de forma gradual, sin hipotensión ortostática en ancianos); tratar aunque esté bajo 140/90.
- Con albuminuria (RAC ≥30 mg/g): IECA o ARA-II obligatorio (enalapril o losartán), que dilatan la arteriola eferente y reducen la proteinuria.

- Sin albuminuria: cualquier primera línea (IECA, ARA-II, amlodipino o tiazida). Betabloqueador solo si hay IAM previo o insuficiencia cardíaca.
- PA ≥140/90 al inicio: biterapia de entrada, IECA/ARA-II + amlodipino 5–10 mg o + tiazida.
- Nunca IECA + ARA-II (ONTARGET: más falla renal aguda e hiperkalemia). Controlar creatinina y potasio a las 1–2 semanas de iniciar.
- Seguimiento completo en PSCV: PA en cada control, RAC y VFG anual; con VFG <30 usar furosemida en vez de tiazida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg c/12 h, HbA1c 7,1 %. En sus últimos 3 controles presenta PA promedio de 144/92 mmHg. RAC 160 mg/g (confirmada) y creatinina 1,0 mg/dL. **¿Cuál es el antihipertensivo de primera línea?**

A) Atenolol
B) Hidroclorotiazida
C) Enalapril o losartán
D) Enalapril más losartán
E) Furosemida

Respuesta C. Diabético hipertenso con albuminuria (RAC 30–299 mg/g): IECA o ARA-II, que dilatan la arteriola eferente, bajan la presión intraglomerular y reducen la proteinuria. Meta < 130/80. Con PA ≥ 140/90 se asocia amlodipino. Nunca IECA + ARA-II.

1.02.1.009 Insuficiencia renal y diabetes

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefropatía diabética: primera causa de hemodiálisis; progresa de hiperfiltración a albuminuria y glomeruloesclerosis (Kimmelstiel-Wilson).
- Diagnóstico de ERC: VFG <60 mL/min/1,73 m² (CKD-EPI) y/o RAC ≥30 mg/g por más de 3 meses; etapificar por G (filtración) y A (albuminuria).
- Ajustar fármacos: metformina máx. 1.000 mg con VFG 30–44 y suspender <30; glibenclamida contraindicada <30; linagliptina sin ajuste renal; insulina con dosis menores (más riesgo de hipoglicemia).
- Nefroprotección: IECA o ARA-II (nunca juntos) + iSGLT2 si VFG >20–25; PA <130/80, HbA1c individualizada, evitar AINE y contraste.
- Vigilar hiperkalemia, anemia, acidosis y alteraciones del fósforo/PTH.
- Seguimiento: derivar a nefrología si VFG <30, RAC ≥300 mg/g, caída rápida de VFG o hiperkalemia persistente.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 37

Una paciente de 67 años, monorrena, es diagnosticada recientemente de diabetes mellitus tipo 2. Sus exámenes muestran HbA1c de 8,5%, glicemia de ayuno de 132 mg/dL, creatinina de 4,1 mg/dL, nitrógeno ureico de 68 mg/dL, potasio plasmático de 4,2 mEq/L y un clearance de creatinina estimado de 12 mL/min. Presenta una relación albuminuria/creatinuria de 1.100 mg/g. **¿Qué fármaco es el más adecuado para iniciar el tratamiento?**

A) Metformina
B) Glibenclamida
C) Vildagliptina
D) Dapagliflozina
E) Semaglutida

Respuesta E. Con clearance de 12 mL/min, la metformina y la glibenclamida están contraindicadas; los iSGLT2 necesitan filtración para actuar (glucosuria) y no se inician con esta función renal; la vildagliptina se elimina por el riñón. Los agonistas GLP-1 como la semaglutida son la alternativa a la insulina, con beneficio cardiovascular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 122

Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 e hipertenso, sin controles hace 5 años, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, amlodipino y metformina, Acude a control, con exámenes de laboratorio. Su presión arterial es de 152/96 mmHg y su frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. Entre sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada: 6%, creatinina plasmática: 3,8 mg/dL, natremia: 140 mEq/L y potasemia: 4,8 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener el tratamiento
B) Suspender la metformina
C) Suspender el diurético
D) Suspender el enalapril
E) Suspender el amlodipino

Respuesta B. Con creatinina de 3,8 mg/dL a los 78 años, la filtración está muy por debajo de 30 mL/min: la metformina está contraindicada por riesgo de acidosis láctica. Además, su HbA1c de 6 % indica sobretratamiento para su edad. El enalapril se mantiene: potasio normal y presión aún elevada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 18 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con 500 mg de metformina al día, acude a control, con hemoglobina glicosilada de 8,8%, proteinuria (+) y claerence de creatinina de 50 ml/min. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Subir la dosis de metformina
B) Agregar glibenclamida
C) Agregar insulina NPH nocturna
D) Tratar con mezcla de insulinas
E) Agregar glipizida al tratamiento

Respuesta D. La insuficiencia renal contraindica los hipoglicemiantes orales: se debe dejar insulina. El tratamiento que tenía era pésimo.

1.02.1.010 Nefropatía incipiente

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal · Tema 5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Albuminuria moderada (antigua microalbuminuria): RAC 30–299 mg/g en primera orina matinal; ≥300 es A3.
- Tamizaje: DM2 desde el diagnóstico y DM1 a los 5 años del debut, luego anual; la orina de 24 horas ya no es el estándar.
- Confirmar con 2 de 3 muestras positivas en 3–6 meses; descartar falsos positivos (ITU, fiebre, ejercicio intenso, hematuria, IC aguda).
- Tratamiento: IECA o ARA-II incluso en normotensos, a dosis máxima tolerada; nunca combinar ambos. Agregar iSGLT2 si VFG >20–25.
- Control intensivo de PA (<130/80), glicemia, lípidos (estatina) y suspender tabaco.
- Seguimiento completo en APS: RAC, creatinina y potasio periódicos; derivar si progresa a A3 o cae la VFG.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 54 años con DM2 de 7 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 7,0 %, PA 124/76 mmHg. En su control anual se pide una muestra de orina matinal: razón albúmina/creatinina (RAC) de 48 mg/g. Creatinina 0,8 mg/dL, VFG 90 mL/min. No tiene fiebre, infección urinaria ni ha hecho ejercicio intenso. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir la RAC hasta completar 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses
B) Iniciar losartán por nefropatía diabética
C) Derivar a nefrología para biopsia renal
D) Solicitar orina de 24 horas para proteinuria y repetir en un año
E) Iniciar restricción proteica y control en un año

Respuesta A. La albuminuria varía mucho de un día a otro. La nefropatía incipiente (RAC 30–300 mg/g) se confirma con 2 de 3 muestras alteradas en un plazo de 3 a 6 meses, descartando infección, fiebre o ejercicio. Confirmada, se indica IECA o ARA II.

Pregunta de práctica

Hombre de 53 años con DM2 hace 1 año, en metformina, HbA1c 6,8%, PA habitual 118/76 mmHg. En su control anual en el CESFAM: RAC 84 mg/g. Se repite a los 3 meses: 92 mg/g, con sedimento sin bacterias ni leucocitos. VFG estimada 85 ml/min/1,73 m². **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener el tratamiento, dado que es normotenso
B) Iniciar enalapril y titular progresivamente
C) Iniciar enalapril más losartán para un bloqueo doble
D) Solicitar proteinuria de 24 horas antes de decidir
E) Iniciar hidroclorotiazida

Respuesta B. Dos RAC en rango A2 (30–299 mg/g), sin falsos positivos: albuminuria persistente. Está indicado un IECA o ARA II aunque sea normotenso, porque dilata la arteriola eferente y baja la presión intraglomerular. Nunca IECA más ARA II. La orina de 24 horas ya no es el examen de elección.

1.02.1.011 Neuropatía diabética

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Polineuropatía distal simétrica sensitiva 'en calcetín': parestesias, ardor o dolor nocturno, pérdida de sensibilidad protectora; aquiliano abolido.
- Tamizaje anual con monofilamento 10 g (pulpejos 1.º, 3.º y 5.º y cabezas metatarsianas): un punto no percibido = pie de alto riesgo. Complementar con diapasón 128 Hz y pulsos.
- Componente motor (dedos en garra, cabezas metatarsianas prominentes) y autonómico (anhidrosis, piel seca e hiperqueratósica; gastroparesia, hipotensión ortostática, disfunción eréctil).
- Tratamiento inicial: optimizar control glicémico, educación y cuidado de pies; dolor neuropático con pregabalina, gabapentina, duloxetina o amitriptilina.
- No se pide electromiografía de rutina para el tamizaje; descartar déficit de B12 (metformina), hipotiroidismo y alcohol.
- Seguimiento: derivar si hay dolor refractario, formas atípicas (asimétricas, motoras) o úlcera.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 59 años con DM2 de 12 años de evolución, HbA1c 8,1 %. Asintomático. En su control anual en el CESFAM se examinan los pies: piel íntegra, sin deformidades, pulsos pedios presentes. No percibe el monofilamento de 10 g en 4 de 10 puntos plantares de cada pie y tiene la sensibilidad vibratoria disminuida con diapasón de 128 Hz. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A) Polineuropatía diabética con pérdida de sensibilidad protectora: pie de alto riesgo, educación, calzado adecuado y controles frecuentes
B) Examen normal; repetir en un año
C) Enfermedad arterial periférica; solicitar índice tobillo-brazo urgente
D) Iniciar pregabalina para prevenir úlceras
E) Derivar a neurología para electromiografía antes de clasificar el riesgo

Respuesta A. La pérdida de sensibilidad al monofilamento de 10 g demuestra polineuropatía con pérdida de la sensibilidad protectora, el principal factor de riesgo de úlcera. Se clasifica como pie de riesgo: educación en autocuidado, calzado adecuado, podología y control más frecuente. La electromiografía no es necesaria y la pregabalina es solo para el dolor neuropático.

1.02.1.012 Obesidad

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad: IMC ≥30 kg/m² (sobrepeso 25–29,9); obesidad abdominal por circunferencia de cintura (≥90 cm hombre, ≥80 cm mujer en Chile).
- Evaluar comorbilidades: DM2, HTA, dislipidemia, hígado graso, apnea del sueño, artrosis; descartar hipotiroidismo y Cushing si la clínica sugiere.

- Tratamiento base: déficit de 500–1.000 kcal/día con dieta saludable, actividad física 150 min/semana aeróbica + fuerza 2–3 veces/semana, y terapia conductual. Meta inicial: bajar 5–10 % del peso en 6 meses.
- Fármacos si IMC ≥30, o ≥27 con comorbilidad: agonistas GLP-1 (liraglutida, semaglutida, baja 5–15 %) u orlistat; en el diabético obeso preferir metformina, GLP-1 o iSGLT2.
- Cirugía bariátrica si IMC ≥40, o ≥35 con comorbilidad, tras falla del manejo médico.
- Seguimiento completo: peso, cintura, PA, glicemia y lípidos periódicos; mantener la baja de peso a largo plazo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 20

Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 96 mg/dl, más una insulina basal que resulta 23 UI/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar insulina
B) Iniciar dieta y ejercicio
C) Iniciar metformina
D) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa
E) Iniciar metformina más glibenclamida

Respuesta B. HOMA-IR = 96 × 23 / 405 ≈ 5,5 (> 2,6): resistencia a la insulina. La glicemia de ayuno es normal (< 100), así que no hay diabetes ni glicemia alterada: dieta y ejercicio.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 20

Un adolescente de 16 años, con IMC de 33 kg/m², se realiza una glicemia de ayuno que resulta 96 mg/dL y una insulinemia basal de 23 μUI/mL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar insulina
B) Iniciar dieta y ejercicio
C) Iniciar metformina
D) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa
E) Iniciar metformina más glibenclamida

Respuesta B. Tiene obesidad con resistencia a la insulina (HOMA = 96 × 23 / 405 ≈ 5,5), pero glicemia de ayuno normal, sin diabetes ni prediabetes. El manejo es el cambio de estilo de vida: dieta y actividad física, idealmente con apoyo familiar. La metformina no se indica solo por insulinemia alta en un adolescente.

1.02.1.013 Obesidad mórbida

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad mórbida (clase III): IMC ≥40 kg/m², o ≥35 con comorbilidad grave (DM2, HTA, apnea del sueño, artrosis invalidante).
- Sospechar complicaciones: apnea obstructiva del sueño (ronquido, somnolencia), síndrome de hipoventilación, hígado graso, insuficiencia cardíaca, depresión.
- Manejo inicial: estilo de vida intensivo (dieta hipocalórica, actividad física adaptada) y control de comorbilidades; tamizar DM2, dislipidemia y HTA.
- Indicación de cirugía bariátrica (manga gástrica o bypass gástrico) si IMC ≥40, o ≥35 con comorbilidad, tras falla de tratamiento médico.
- Seguimiento: derivar a equipo multidisciplinario de obesidad/cirugía bariátrica; tras la cirugía suplementar hierro, B12, calcio y vitamina D.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 38 años, con IMC de 42 kg/m², hipertensa y con DM2, ha intentado bajar de peso por más de 2 años con dieta, ejercicio y apoyo farmacológico, sin éxito. No tiene trastorno psiquiátrico descompensado ni consumo de alcohol o drogas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Insistir solo con dieta hipocalórica estricta
B) Indicar liposucción
C) Indicar ayuno intermitente prolongado
D) Iniciar levotiroxina para aumentar el gasto energético
E) Derivar a evaluación multidisciplinaria para cirugía bariátrica

Respuesta E. Con IMC ≥40 kg/m², o ≥35 con comorbilidades, y fracaso del tratamiento médico, la cirugía bariátrica (manga gástrica o bypass) es la terapia más eficaz para bajar de peso en forma sostenida y mejora la diabetes y la HTA. Requiere evaluación multidisciplinaria previa. La liposucción no trata la obesidad ni sus comorbilidades.

1.02.1.014 Pié diabético y otras infecciones en diabetes

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico · Tema 14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie diabético: neuropatía (>80 %) + isquemia + traumatismo. Úlcera neuropática indolora en zona de apoyo con pulsos presentes; isquémica dolorosa, distal y con pulsos ausentes.
- Clasificación de Wagner: 0–2 ambulatorio (descarga + curación avanzada); 3–5 (absceso, osteomielitis, gangrena) hospitalizar. Estilete que toca hueso = osteomielitis (Wagner 3).
- Cultivo de tejido profundo o biopsia ósea, nunca hisopado superficial. Radiografía o RM si sospecha osteomielitis; pulsos ausentes: índice tobillo-brazo.
- Antibióticos: leve (celulitis <2 cm) cefadroxilo o cloxacilina VO 7–14 días; moderada amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino + clindamicina; severa ceftriaxona + metronidazol EV.
- Otras infecciones típicas del diabético: otitis externa maligna (anciano, Pseudomonas, granulación en piso del conducto; ciprofloxacino o ceftazidima EV 6–8 semanas), mucormicosis, pielonefritis enfisematosa.
- Seguimiento: derivar Wagner ≥3, gangrena o isquemia (estudio vascular antes de resecar).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 93

DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta: **¿Cuál es la conducta?**

A) Mejorar calzado
B) Electromiografia, realizar test de nuevo en unos meses
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta A. Pie de riesgo sin úlcera (dedos en garra, hiperqueratosis, monofilamento alterado): Wagner 0. La conducta es preventiva: calzado adecuado, educación y podología. No es una urgencia y no requiere electromiografía.

1.02.1.015 Retinopatía diabética

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES · Tema 15.12 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad silenciosa: se busca con fondo de ojo o retinografía no midriática, en DM2 al diagnóstico y luego anual; en DM1 desde los 5 años del debut (GES).
- Lesión más precoz: microaneurismas. No proliferativa: microhemorragias, exudados duros (fuga) y algodonosos (isquemia); severa por regla 4-2-1.
- Proliferativa: definida por neovasos en papila o retina; complicaciones hemorragia vítrea, desprendimiento traccional y glaucoma neovascular.

- Pérdida visual súbita e indolora con rojo pupilar abolido = hemorragia vítrea: derivar de inmediato. Edema macular: causa más frecuente de baja visual moderada, en cualquier etapa.
- Manejo inicial: control estricto de HbA1c y PA; derivar a oftalmología. Tratamientos GES: panfotocoagulación láser (proliferativa) y anti-VEGF intravítreo (edema macular).
- Seguimiento: derivar; anual si no hay retinopatía o es leve, más frecuente en etapas avanzadas.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 63 años con DM2 de 14 años de evolución, HbA1c 8,4 %, hipertensa. Consulta por visión borrosa progresiva del ojo derecho de 3 meses, sin dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/60 en el ojo derecho. El fondo de ojo muestra microaneurismas, exudados duros en anillo y engrosamiento retinal que compromete el centro de la fóvea, sin neovasos. La tomografía de coherencia óptica confirma edema macular. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Panfotocoagulación con láser
B) Inyecciones intravítreas de anti-VEGF
C) Vitrectomía
D) Solo optimizar el control glicémico y repetir fondo de ojo en un año
E) Corticoides tópicos

Respuesta B. El edema macular es la causa más frecuente de baja visual moderada en la diabetes. Cuando compromete el centro de la fóvea, la primera línea son las inyecciones intravítreas de anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept). La panfotocoagulación con láser se reserva para la retinopatía proliferativa, con neovasos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

pte diabetico con fondo de ojo alterado tenia buen control metabolico, cual era la medida mas adecuada

A) Pioglitazona
B) Sitagliptina
C) Insulina NPH
D) Glibenclamida
E) subir metformina??

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Glibenclamida). subir metformina??. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera adquirida en adultos en edad laboral. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

1.02.1.016 Síndrome metabólico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico (ATP III): 3 o más de 5 criterios: cintura ≥90 cm hombre / ≥80 cm mujer, PA ≥130/85, glicemia de ayuno ≥100, TG ≥150, HDL <40 en hombres o <50 en mujeres.
- Eje fisiopatológico: resistencia a la insulina; marcadores clínicos acantosis nigricans y acrocordones. HOMA-IR >2,6 indica resistencia.
- Implica alto riesgo de DM2 y enfermedad cardiovascular; evaluar hígado graso, apnea del sueño y síndrome de ovario poliquístico.
- Tratamiento: cambio intensivo del estilo de vida (baja de 5–10 % del peso, dieta mediterránea, 150 min/semana de ejercicio); es la intervención más efectiva.
- Tratar cada componente según metas: estatina si el riesgo lo indica, antihipertensivos, metformina si hay prediabetes de alto riesgo.
- Seguimiento completo en APS: peso, cintura, PA, glicemia y perfil lipídico periódicos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 42

Un paciente de 30 años, con IMC de 30 kg/m², consulta por hiperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociada a la aparición de acrocordones en los pliegues inguinales, cervicales y axilares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Cushing
B) Hipotiroidismo
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Resistencia a la insulina

Respuesta E. La acantosis nigricans en pliegues con acrocordones en un paciente obeso es el marcador cutáneo clásico de resistencia a la insulina, eje del síndrome metabólico. La forma paraneoplásica es rara, brusca, extensa y en mayores que bajan de peso. La insuficiencia suprarrenal hiperpigmenta mucosas y cicatrices, sin acrocordones.

1.02.1.017 Síndromes carenciales de vitaminas y minerales

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.19 Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit de vitamina D: medir 25(OH)D (no calcitriol). <20 ng/mL deficiencia, 20–29 insuficiencia, 30–50 suficiente. Riesgo: adulto mayor institucionalizado, sin sol, malabsorción.
- Osteomalacia: dolor óseo, miopatía proximal, FA alta, fósforo bajo, PTH alta; líneas de Looser-Milkman. Tratar con colecalciferol 50.000 UI semanal por 8 semanas y luego 1.000–2.000 UI/día + calcio.
- Déficit de B12: anemia macrocítica, glositis, neuropatía y deterioro cognitivo; causas anemia perniciosa, metformina, gastrectomía, veganismo. Reponer B12 IM.
- Déficit de hierro (anemia microcítica, ferritina baja) y de ácido fólico (macrocítica, alcohol, embarazo); tiamina: Wernicke y beriberi en alcohólicos.
- Otros: zinc (dermatitis acral, diarrea), vitamina A (ceguera nocturna), vitamina C (escorbuto, encías sangrantes), vitamina K (coagulopatía en malabsorción).
- Seguimiento: buscar y tratar la causa; derivar si hay malabsorción o déficit sin causa clara. No iniciar bifosfonatos antes de reponer vitamina D.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Mujer de 78 años, residente de un ELEAM en Valdivia, sin exposición solar. Astenia, dolor difuso en pelvis y piernas, debilidad proximal y marcha anadeante. Ca 8,4 mg/dL (albúmina 3,9), P 2,0 mg/dL, FA 340 U/L (VN < 120), PTH 115 pg/mL, 25(OH)D 8 ng/mL. Rx de pelvis: bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en ambos cuellos femorales. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Alendronato 70 mg semanal más calcio
B) Colecalciferol 50.000 UI semanal por 8 semanas más calcio 1.000 mg/día
C) Colecalciferol 800 UI/día sin calcio
D) Paratiroidectomía
E) Solicitar 1,25(OH)2D antes de tratar

Respuesta B. Dolor óseo, miopatía proximal, P bajo, FA y PTH altas, 25(OH)D de 8 y líneas de Looser-Milkman: osteomalacia por déficit severo de vitamina D. Carga de colecalciferol 50.000 UI semanal por 8 semanas con calcio, y luego mantención 1.000–2.000 UI/día. Los bifosfonatos están contraindicados en la osteomalacia no corregida.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?

A) Fierro
B) Ácido fólico
C) Cianocobalamina
D) Zinc
E) Tiamina

Respuesta C. Tiene un déficit de B12, tanto por el antecedente de by-pass como por la macrocitosis y plaquetopenia. La ferritina está normal (VN: 15 a 300).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 25 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 34 años, con antecedente de by pass gástrico hace 2 años, por obesidad mórbida, consulta por astenia, disnea y marcada fatigabilidad y debilidad de extremidades inferiores. Al examen físico tiene paresia M4 de ambas extremidades inferiores, con disminución de la sensibilidad distal e hiporreflexia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 20%, glóbulos blancos: 3.100 por mm3 y plaquetas: 93.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desnutrición proteica
B) Déficit de zinc
C) Déficit de fosfatos
D) Déficit de niacina
E) Déficit de cianocobalamina

Respuesta E. Es un déficit de B12 clásico. Recordar que el déficit de B6 (piridoxina) es el causado por el consumo crónico de isoniazida (ej. TBC o PFX TBC) y se presenta como una polineuropatía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, vegetariana estricta, con antecedente de un hijo con mielomeningocele, presenta anemia. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Vitamina B12
B) Folatos
C) Tiamina
D) Ácidos grasos omega 3
E) Aminoácidos esenciales

Respuesta B. Por ser vegetariana también debe recibir B12, pero los folatos son lo más importante por el mielomeningocele (defecto del tubo neural)

1.02.1.018 Trastornos de conducta alimentaria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Anorexia nerviosa: restricción de ingesta con peso significativamente bajo, miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; subtipos restrictivo y purgativo.
- Bulimia nerviosa: atracones recurrentes con conductas compensatorias (vómitos, laxantes, ejercicio) al menos 1 vez/semana por 3 meses, con peso habitualmente normal; signo de Russell, hipertrofia parotídea, erosión dental.
- Trastorno por atracón: atracones sin conductas compensatorias, asociado a obesidad.
- Evaluar gravedad: IMC (<15 extrema), bradicardia, hipotensión, hipotermia, hipokalemia, alcalosis metabólica (vómitos), QT largo, amenorrea, osteopenia.
- Hospitalizar si FC <40–50, PA muy baja, hipokalemia, IMC muy bajo, ideación suicida o falla del tratamiento ambulatorio; realimentar lento por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría/equipo multidisciplinario (psicoterapia, nutrición; ISRS como fluoxetina en bulimia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 17 años es traída por su madre, que encontró envoltorios de comida escondidos. Refiere episodios de ingesta de grandes cantidades de comida con sensación de pérdida de control, 3 veces por semana desde hace 4 meses, seguidos de vómitos autoinducidos. Su IMC es 22 kg/m². Al examen tiene hipertrofia parotídea y callosidades en el dorso de la mano. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anorexia nerviosa restrictiva
B) Trastorno de rumiación
C) Trastorno por atracón
D) Bulimia nerviosa
E) Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos

Respuesta D. Atracones con pérdida de control y conductas compensatorias (vómitos) al menos una vez por semana durante 3 meses, con peso normal, definen bulimia nerviosa; la hipertrofia parotídea y el signo de Russell son típicos. En el trastorno por atracón no hay conductas compensatorias y en la anorexia el peso es bajo. Se debe controlar el potasio.

1.02.1.019 Vasculopatía periférica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad arterial periférica: claudicación intermitente (dolor en pantorrilla al caminar que cede con reposo); en el diabético puede ser silente por la neuropatía.
- Signos: pulsos pedio y tibial posterior disminuidos o ausentes, palidez al elevar y rubor al declive, piel fría, atrófica, sin vello; úlcera isquémica distal dolorosa.
- Sospecha confirmada con índice tobillo-brazo <0,9 (en el diabético puede salir falsamente alto >1,3 por calcificación).
- Isquemia crítica (dolor de reposo, úlcera o gangrena) o isquemia aguda (6 P: dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis, poiquilotermia): derivación urgente a cirugía vascular.
- Manejo inicial: suspender tabaco, ejercicio supervisado, AAS o clopidogrel, estatina de alta intensidad, control de PA y glicemia; cilostazol para la claudicación.
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular para eco-Doppler/angiografía y evaluar revascularización.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 64 años, diabético y fumador, refiere dolor en ambas pantorrillas al caminar 200 metros, que cede a los pocos minutos de reposo. Los pulsos pedios están disminuidos y el índice tobillo-brazo es 0,7. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Cesación tabáquica, ejercicio supervisado, estatina y antiagregante plaquetario
B) Revascularización quirúrgica inmediata
C) Anticoagulación oral
D) Amputación infracondílea
E) Reposo absoluto en cama

Respuesta A. Claudicación intermitente con ITB bajo 0,9 confirma enfermedad arterial periférica. El manejo inicial es reducir el riesgo cardiovascular (dejar de fumar, estatina de alta intensidad, antiagregante, control de diabetes y PA) más ejercicio supervisado, que aumenta la distancia de marcha. La revascularización se reserva para isquemia crítica o claudicación invalidante.

Situaciones clínicas de urgencia 7 códigos

1.02.2.001 Acidosis láctica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas

QUÉ HAY QUE SABER

- Acidosis metabólica con anion gap aumentado y lactato >4–5 mmol/L; la asociada a metformina tiene mortalidad 40–50 %.

- Gatillantes: hipoperfusión o hipoxemia (shock, sepsis, IC, IRA) en paciente usuario de metformina, sobre todo con VFG <30, falla hepática o alcohol; también contraste yodado.
- Clínica: náuseas, vómitos, dolor abdominal, taquipnea (Kussmaul), compromiso de conciencia, hipotensión.
- Manejo inicial: suspender metformina, soporte hemodinámico con fluidos y oxigenación, tratar la causa; hemodiálisis en casos graves (elimina la metformina).
- Prevención: suspender metformina con VFG <30, 48 h antes de contraste o cirugía, y al hospitalizarse por sepsis o hipoxemia.
- Seguimiento: derivar a UPC; no reiniciar metformina hasta recuperar función renal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas desde hace 8 años, sin controles recientes. Consulta por 3 días de vómitos, dolor abdominal difuso y decaimiento. Está taquipneico, con respiración profunda, PA 95/60 mmHg. Glicemia 165 mg/dL, cetonemia negativa, creatinina 3,4 mg/dL (VFG 18 mL/min), pH 7,08, HCO3 7 mEq/L, anión gap 26, lactato 11 mmol/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cetoacidosis diabética
B) Hipoglicemia por metformina
C) Estado hiperglicémico hiperosmolar
D) Acidosis tubular renal
E) Acidosis láctica asociada a metformina

Respuesta E. Acidosis metabólica grave con anión gap elevado, lactato alto, cetonas negativas y glicemia casi normal en un usuario de metformina con falla renal: acidosis láctica asociada a metformina. Se suspende la metformina y la hemodiálisis corrige la acidosis y elimina el fármaco.

1.02.2.002 Cetoacidosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) · Tema 4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH · Tema 4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato · Tema 4.4 Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea · Tema 4.5 Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios: glicemia >250 mg/dL, pH <7,30 y HCO_3 <18 mEq/L, anion gap >10–12 y cetonas positivas (β-hidroxibutirato >3 mmol/L). Severa si pH <7,00 o HCO_3 <10 (UCI).
- Joven DM1 (debut o abandono de insulina), instalación <24 h: dolor abdominal y vómitos que simulan abdomen agudo, Kussmaul y aliento cetósico. Buscar gatillante: infección la n.º 1. Con iSGLT2 puede ser euglicémica.
- Hora 1: suero fisiológico 1.000–1.500 mL (15–20 mL/kg), antes que la insulina; luego NaCl 0,45 % si Na corregido ≥135 o 0,9 % si <135. Reponer el déficit (3–6 L) en 24–48 h.
- Potasio antes de la insulina: K <3,3 no dar insulina y reponer KCl 20–30 mEq/h; 3,3–5,2 insulina + KCl; >5,2 insulina sola. Insulina cristalina EV 0,1 UI/kg/h; meta bajar 50–75 mg/dL/h.
- Con glicemia ≤200 agregar SG 5 % y bajar la insulina a la mitad, sin suspenderla. Bicarbonato solo si pH <6,90.
- Resuelta con glicemia <200 + 2 de 3 (HCO_3 ≥18, pH venoso >7,30, AG ≤12); insulina basal SC 1–2 h antes de apagar la bomba. Vigilar edema cerebral (niños, 4–12 h). Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 16

Un joven de 14 años, deportista de alto rendimiento, consulta por un cuadro de poldipsia y poliuria de 3 semanas de evolución, al que hace 7 días se agrega astenia, náuseas y malestar general. Refiere marcada debilidad, después de realizar ejercicio. Se solicitan exámenes, en las que destaca glicemia: 312 mg/dl, Na+: 132 mEq/L, K+: 5,0 mEq/L, pH sanguíneo: 7,26, bicarbonato plasmático: 11 mEq/L, exceso de base: -13. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperglicemia secundaria al ejercicio
B) Cetoacidosis diabética
C) Debut de diabetes tipo 2
D) Diabetes insípida descompensada
E) Coma hiperosmolar

Respuesta B. Glicemia > 250 mg/dL con acidosis metabólica (pH < 7,30 y HCO_3 < 18) en un adolescente con síntomas cardinales: cetoacidosis diabética como debut de una DM1. No es hiperosmolar: la glicemia es < 600 y hay acidosis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 54

Un paciente de 20 años presenta un cuadro de poliuria y polidipsia, de 2 días de evolución, a lo que se ha agregado dolor abdominal y vómitos hace pocas horas. Se solicita una glicemia, que resulta 360 mg/dl. **¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?**

A) Cetonemia
B) Creatininemia
C) Perfil lipídico
D) Hemoglobina glicosilada
E) Hemograma

Respuesta A. Joven con síntomas cardinales, dolor abdominal, vómitos y glicemia > 250: sospecha de cetoacidosis. Lo urgente es confirmarla con cetonemia (junto con gases venosos). La HbA1c no cambia la conducta en la urgencia.

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años con DM1, en tratamiento por cetoacidosis diabética severa. Recibió 1.500 ml de NaCl 0,9% en la primera hora y luego insulina cristalina en infusión. A las 5 horas: hemoglucotest 188 mg/dL, pH 7,21, HCO_3 12 mEq/L, anion gap 18 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la infusión de insulina hasta que la glicemia vuelva a subir
B) Agregar suero glucosado al 5% y reducir la infusión de insulina a la mitad
C) Pasar a insulina NPH subcutánea y suspender los fluidos
D) Mantener la misma infusión de insulina con NaCl 0,9%
E) Administrar bicarbonato para corregir el pH y suspender la insulina

Respuesta B. La glicemia ya está ≤ 200 mg/dL, pero la cetoacidosis no está resuelta (pH < 7,30, HCO_3 < 18, gap abierto). Se mantiene la insulina a menor dosis (0,02–0,05 UI/kg/h) y se agrega SG 5% para evitar la hipoglicemia mientras se cierra el gap.

Pregunta de práctica

Hombre de 24 años con DM1, hospitalizado hace 10 horas por cetoacidosis diabética, con insulina cristalina EV en bomba. Control: glicemia 165 mg/dL, pH venoso 7,21, bicarbonato 12 mEq/L, anion gap 19 mEq/L, K 4,3 mEq/L. Está somnoliento y con náuseas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la bomba, ya que la glicemia es menor de 200 mg/dL
B) Inyectar glargina subcutánea y apagar la bomba en ese mismo momento
C) Mantener la insulina EV y agregar suero glucosado al 5%
D) Administrar bicarbonato de sodio para cerrar el anion gap
E) Cambiar a insulina cristalina subcutánea según hemoglucotest

Respuesta C. La glicemia está bajo 200, pero no cumple ninguno de los tres criterios ácido-base (pH 7,21, HCO3 12, anion gap 19) y no tolera vía oral: la cetoacidosis no está resuelta. Se mantiene la insulina EV y se agrega SG 5% para sostener la glicemia en 150–200 mg/dL. No hay traslape sin resolución, y el pH de 7,21 no indica bicarbonato.

Pregunta de práctica

Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de control muestran: glicemia 168 mg/dL, pH venoso 7.33, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap 11 mEq/L. Se encuentra lúcido y solicita alimentarse. **¿Cuál es el procedimiento correcto para suspender la bomba de insulina endovenosa y realizar la transición a insulina subcutánea?**

A) Suspender la bomba de infusión endovenosa inmediatamente y esperar 4 horas antes de aplicar la primera dosis subcutánea
B) Inyectar la primera dosis de insulina basal subcutánea y apagar la bomba endovenosa simultáneamente en ese mismo instante
C) Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla
D) Administrar solo insulina ultrarrápida subcutánea cuando la glicemia supere los 250 mg/dL en controles posteriores
E) Mantener la bomba de insulina endovenosa por 48 horas adicionales sin aportar alimentos por boca

Respuesta C. Cumple los criterios de resolución y tolera la vía oral. Como la insulina EV tiene vida media de 5 a 9 minutos y la basal SC tarda 1 a 2 horas en absorberse, se inyecta la basal y la bomba se mantiene 1 a 2 horas más. Apagarla junto con el pinchazo deja un hueco sin insulina y una cetoacidosis de rebote.

Pregunta de práctica

Mujer de 20 años con DM1 en tratamiento por cetoacidosis diabética, con insulina cristalina EV y suero fisiológico. A las 7 horas se torna confusa, sudorosa y temblorosa. PA 118/72 mmHg, FC 112 lpm. Hemoglucotest: 48 mg/dL. Nunca se agregó suero glucosado a la hidratación. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manitol al 20% EV y reducir la velocidad de los fluidos
B) TAC de cerebro urgente
C) Glucosa al 30% EV en bolo y agregar suero glucosado al 5%
D) Fosfato de potasio EV
E) Bicarbonato de sodio EV

Respuesta C. Confusión con diaforesis, temblor, taquicardia y glicemia de 48 mg/dL: hipoglicemia por no agregar SG 5% al bajar la glicemia manteniendo la insulina. Se trata con glucosa al 30% EV en bolo (20–50 ml) y se agrega SG 5%. No hay tríada de Cushing: la presión es normal y la frecuencia está alta, no baja.

Pregunta de práctica

Un adolescente de 13 años se encuentra hospitalizado en la UCI recibiendo tratamiento para una cetoacidosis diabética severa. A las 6 horas de iniciada la fluidoterapia y la insulina endovenosa, el paciente refiere cefalea intensa y presenta dos vómitos explosivos, tornándose progresivamente somnoliento y desorientado. Al monitor se observa un ascenso de la PA de 105/65 a 140/90 mmHg y un descenso de la FC de 102 a 54 lpm. **¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Trasladar de urgencia a tomografía axial computarizada de encéfalo para confirmar el diagnóstico
B) Administrar inmediatamente Manitol al 20% por vía endovenosa (o Solución Salina al 3%) y reducir la velocidad de los fluidos
C) Aumentar la velocidad de infusión de suero fisiológico para tratar el shock hipovolémico
D) Indicar una dosis de atropina endovenosa para revertir la bradicardia sinusal
E) Suspender la insulina y administrar 4 ampollas de glucosa al 30% en bolo

Respuesta B. Edema cerebral con respuesta de Cushing (hipertensión y bradicardia, con cefalea, vómitos explosivos y deterioro de conciencia) a las 6 horas de tratamiento. Manitol al 20% (0,5–1 g/kg EV en 20 minutos) o NaCl 3% (5 ml/kg) de inmediato, al lado de la cama, y reducir los fluidos. Retrasar el tratamiento por una TAC arriesga la herniación.

Pregunta de práctica

Un paciente de 28 años hospitalizado en tratamiento de cetoacidosis diabética presenta debilidad muscular generalizada profunda e insuficiencia ventilatoria aguda con incapacidad para sostener el esfuerzo inspiratorio tras 18 horas de evolución. Sus exámenes demuestran: glicemia 170 mg/dL, pH 7.35, bicarbonato 20 mEq/L, sodio 138 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, calcio 9.2 mg/dL y fósforo inorgánico de 0.8 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento específico indicado?**

A) Gluconato de calcio al 10% endovenoso
B) Sulfato de magnesio endovenoso
C) Suplementación endovenosa con Fosfato de Potasio
D) Aumento de la dosis de insulina cristalina
E) Bicarbonato de sodio al 2/3 molar

Respuesta C. Hipofosfemia severa sintomática (fósforo 0,8 mg/dL, menor de 1,0): el fósforo es necesario para el ATP y el 2,3-DPG, y su déficit produce debilidad diafragmática y falla ventilatoria. Con potasio y calcio normales, el tratamiento específico es fosfato de potasio EV en infusión lenta.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Cetoacidosis cetonas (+) pH 7.1 K 3 conducta inicial hidratar SF

A) Observación clínica
B) Derivar a urgencia
C) Control ambulatorio
D) Solicitar exámenes complementarios
E) Hospitalizar para estudio

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Observación clínica (opción A). PaO2 normal: 75-100 mmHg. Hipoxemia: < 75 mmHg. Insuficiencia respiratoria: < 60 mmHg (equivale aprox. a SatO2 90%). De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.02.2.003 Coma hiperosmolar

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) · Tema 4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

QUÉ HAY QUE SABER

- Estado hiperglicémico hiperosmolar: adulto mayor DM2, instalación insidiosa en días a semanas con poliuria, deshidratación extrema (8–12 L) y compromiso de conciencia (puede simular ACV).
- Criterios: glicemia >600 mg/dL, osmolaridad efectiva >320 mOsm/kg (2×Na + glicemia/18), pH >7,30, HCO_3 >18 y cetonas ausentes o trazas.
- Buscar gatillante: infección (neumonía, ITU), IAM, ACV, corticoides, omisión de tratamiento.
- Manejo inicial: volumen primero, SF 0,9 % 1.000–1.500 mL la primera hora; luego según Na corregido. Insulina EV 0,1 UI/kg/h tras hidratar y con K ≥3,3; SG 5 % cuando la glicemia llegue a 300.
- Corrección lenta: osmolaridad ≤3 mOsm/kg/h y déficit en 24–48 h para evitar edema cerebral. Resuelto con osmolaridad <315, glicemia <250–300 y paciente lúcido.
- Seguimiento: no requiere seguimiento específico de la crisis; continuar el control de su diabetes (habitualmente con insulina) tras el alta.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 39

Un paciente de 70 años presenta un cuadro de malestar general y poliuria de dos semanas de evolución, agregándose desorientación y compromiso de conciencia cuantitativo en las últimas 48 horas. En su examen, no presenta focalidad neurológica y sus laboratorios revelan glicemia: 950 mg/dL, pH venoso: 7,37, bicarbonato: 18 mEq/L, cetonemia (-), cetonuria (+), sodio plasmático: 149 mEq/L y potasio plasmático: 5,0 mEq/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Coma hiperosmolar no cetósico
B) Cetoacidosis diabética
C) Síndrome hiperglicémico mixto (hiperosmolar + cetoacidosis)
D) Hipernatremia sintomática
E) Edema cerebral

Respuesta A. Adulto mayor, dos semanas de poliuria, compromiso de conciencia, glicemia > 600 sin acidosis (pH 7,37) y cetonemia negativa. Osmolaridad efectiva: 2 × 149 + 950/18 ≈ 351 mOsm/kg (> 320). Una cetonuria aislada no hace una cetoacidosis.

Pregunta de práctica

Mujer de 80 años con DM2, ingresada en coma por estado hiperglicémico hiperosmolar: glicemia 950 mg/dL, Na 142 mEq/L, osmolaridad efectiva 360 mOsm/L, sin cetosis. Recibió 4 litros de suero fisiológico en 3 horas e insulina en bomba a 0,14 UI/kg/h, sin agregar suero glucosado. A las 6 horas la glicemia es de 210 mg/dL; tras recuperar parcialmente la conciencia, presenta cefalea, bradicardia, vómitos y una convulsión tónico-clónica. **¿Cuál es la causa más probable del deterioro?**

A) Hipoglicemia por la infusión de insulina
B) Accidente cerebrovascular hemorrágico por hipertensión
C) Hipernatremia por el suero fisiológico
D) Cetoacidosis diabética sobreagregada
E) Edema cerebral por descenso demasiado rápido de la osmolaridad

Respuesta E. En el coma hiperosmolar la neurona se adaptó al medio hiperosmolar. Si la glicemia y la osmolaridad caen bruscamente (aquí 740 mg/dL en 6 horas), el agua entra a la célula y aparece edema cerebral. La glicemia debe bajar 50 a 75 mg/dL por hora, con suero glucosado al llegar a 300 mg/dL.

1.02.2.004 Déficit agudo de tiamina

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina (B1): alcohólico crónico, desnutrición, hiperémesis, cirugía bariátrica o realimentación.
- Tríada: oftalmoplejía/nistagmo (VI par), ataxia de la marcha y síndrome confusional; puede aparecer en cualquier momento, no solo en la abstinencia. Diagnóstico clínico.
- Regla de oro: tiamina EV o IM antes (o junto) de cualquier suero glucosado; la glucosa sola consume la tiamina y precipita el daño de cuerpos mamilares.
- Tratamiento: tiamina parenteral en dosis altas (200–500 mg EV cada 8 h por 3–5 días en Wernicke establecido; profilaxis 100–300 mg/día), luego oral; corregir magnesio.
- Sin tratamiento evoluciona a síndrome de Korsakoff (amnesia anterógrada y confabulación), irreversible.

- Seguimiento: derivar para manejo de la dependencia alcohólica (naltrexona, disulfiram, apoyo psicosocial) y nutricional.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un hombre de 45 años, con consumo crónico de alcohol y operado de bypass gástrico hace 1 año, es traído por confusión, marcha atáxica y visión doble de 1 semana. Al examen tiene nistagmo y paresia bilateral del VI par. La glicemia capilar es 65 mg/dL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Administrar suero glucosado y luego evaluar
B) Administrar tiamina endovenosa antes o junto con la glucosa
C) Solicitar RM de encéfalo y esperar el resultado
D) Iniciar vitamina B12 intramuscular
E) Indicar haloperidol para la confusión

Respuesta B. Confusión, ataxia y oftalmoplejía en un alcohólico o post cirugía bariátrica es encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, una urgencia. Se da tiamina endovenosa en dosis altas antes o junto con la glucosa, porque la glucosa sola consume la tiamina residual y puede empeorar el cuadro. El diagnóstico es clínico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Hombre con antecedente de cirugía bariátrica hace 1 año+consumo de OH desde hace 7 meses, deja de asistir a control médico, parte con 1 semana de evolución de ataxia, dificultad de la marcha, visión doble,confusión, somnolencia, cual es la deficiencia:

A) Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).
B) Vitamina B12
C) Vitamina C
D) Laparotomía exploratoria
E) Cirugía laparoscópica

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

1.02.2.005 Hipertrigliceridemia grave

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

QUÉ HAY QUE SABER

- TG >500–1.000 mg/dL: el riesgo principal es la pancreatitis aguda (más necrotizante); suero lactescente y xantomas eruptivos.
- Causas: diabetes descompensada, alcohol, obesidad, hipotiroidismo, embarazo, fármacos (estrógenos, corticoides, retinoides) sobre una predisposición genética.
- 500–999 riesgo inminente; ≥1.000 crítico: fibrato inmediato (fenofibrato 160–200 mg/día o gemfibrozilo 600 mg c/12 h), cero alcohol y dieta con grasas <15–20 % de las calorías, sin azúcares simples.
- Si hay que asociar estatina, usar fenofibrato; nunca gemfibrozilo + estatina (rabdomiólisis).
- Con pancreatitis: manejo hospitalario de la pancreatitis, insulina EV (baja TG) y eventualmente plasmaféresis; controlar glicemia.
- Seguimiento: derivar a especialista si TG persisten altos o hay pancreatitis.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 47 años, con obesidad, DM2 en tratamiento con metformina y consumo de 5 cervezas diarias. Asintomático. En un control se informa suero lactescente, triglicéridos 1.450 mg/dL, colesterol total 310 mg/dL, HDL 26 mg/dL. Lipasa normal. Examen abdominal sin dolor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar atorvastatina 80 mg/día
B) Solo dieta y control en 6 meses, ya que está asintomático
C) Iniciar ezetimibe y controlar en 3 meses
D) Iniciar fibrato, suspender completamente el alcohol y dieta muy baja en grasas
E) Agregar gemfibrozilo a una estatina en dosis alta

Respuesta D. Triglicéridos sobre 1.000 mg/dL: hipertrigliceridemia grave con alto riesgo de pancreatitis aguda. La prioridad deja de ser el LDL; se inicia de inmediato un fibrato, se suspende totalmente el alcohol y se indica una dieta prácticamente sin grasas, además de optimizar el control glicémico. El gemfibrozilo no se combina con estatinas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 45 años, obeso (con IMC:35) y diabético, en tratamiento con metformina y empaglifozina y con antecedente de consumo de 4 cervezas diarias, acude a chequeo. Trae múltiples exámenes, entre los que destaca perfil lipídico con colesterol LDL: 135 mg/dl, colesterol HDL: 27 mg/dl y triglicéridos: 1.000 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente en este momento?

A) Enviar al servicio de urgencias
B) Iniciar gemfibrozilo 900 mg/día
C) Iniciar rosuvastatina 40 mg/día
D) Iniciar ezetimibe 10 mg/día
E) Iniciar dieta estricta

Respuesta E. Manejo de Hipertrigliceridemia Severa: En un paciente con dislipidemia mixta el objetivo suele ser bajar el colesterol LDL, a menos que los triglicéridos sean > 500 mg/dL, en que la prioridad es bajar los triglicéridos. Con niveles > 1000 mg/dL, hay alto riesgo de pancreatitis, por lo que se debe manejar urgentemente. Hace años incluso se recomendaba hospitalizarlos para el manejo, sin embargo esa

1.02.2.006 Hipoglicemias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular · Tema 2.2 Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas · Tema 3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis · Tema 3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Niveles: 1 <70 mg/dL; 2 <54 mg/dL; 3 severa = compromiso de conciencia o requiere un tercero. Confirmar con tríada de Whipple.
- Síntomas autonómicos (<70: sudor, temblor, taquicardia, hambre) y neuroglucopénicos (<54: confusión, convulsiones, coma). El propranolol enmascara la alarma, salvo la sudoración.
- Consciente: regla de los 15 (15 g de azúcar, control en 15 min, repetir) y luego colación compleja. Inconsciente con vía: glucosa 30 % 20–50 mL EV + SG 10 %; sin vía: glucagón 1 mg IM/SC (ineficaz en alcohol o desnutrición).
- Por glibenclamida: aunque despierte, hospitalizar 24–48 h con SG 10 % y HGT cada 1–2 h; suspender la sulfonilurea.
- Ajustar el tratamiento: buscar causa (omisión de comida, ejercicio, ERC, exceso de insulina, Somogyi) y relajar metas en adulto mayor.
- No diabético: muestra crítica con glicemia <55 (insulina, péptido C, sulfonilureas). Insulina alta + péptido C bajo = insulina exógena; ambos altos con screening negativo = insulinoma.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 72

Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida 15 mg/día, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes desde hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de ayuno de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. **¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?**

A) Hipomagnesemia
B) Hipernatremia
C) Hipoglicemia
D) Hipocalcemia
E) Cetoacidosis

Respuesta C. La glibenclamida tiene alto riesgo de hipoglicemia, sobre todo en el adulto mayor. Una glicemia alta hace 3 días no impide que ahora esté baja: es típico que el paciente mal controlado refuerce por su cuenta la dosis.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 40

Un paciente de 67 años, diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina 1700 mg/día y glibenclamida 20 mg/día, ambos separados en dos dosis diarias consulta por episodios repetidos de mareos, malestar y sudoración, asociado a temblor, que ocurren al final de la mañana o antes de almuerzo. Han coincidido con glicemias capilares de 65 mg/dl. Su IMC es 32 Kg/m2. Su hemoglobina A1c resulta 8,1. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la glibenclamida
B) Agregar una colación con 25 gramos de hidrato de carbono antes del almuerzo
C) Suspender la glibenclamida
D) Reemplazar la glibenclamida por sitagliptina
E) Reemplazar la metformina por pioglitazona

Respuesta D. Las hipoglicemias son causadas por la glibenclamida, que debe cambiarse por otro hipoglicemiante sin riesgo de hipoglicemia. Como el control metabólico es malo (HbA1c 8,1), no basta con suspenderla ni con agregar una colación.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 119

Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulinodependiente, en tratamiento con insulina NPH 30 U en la mañana y 20 U en la noche, presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, que respondió a la ingesta de azúcar, constatándose un hemoglucotest de 50 mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Disminuir la insulina NPH matinal
B) Modificar los horarios de las insulinas
C) Disminuir la insulina NPH nocturna
D) Suspender la insulina NPH nocturna
E) Disminuir ambas dosis de insulina NPH

Respuesta C. La NPH nocturna es la que actúa a las 3 AM, así que es la responsable de la hipoglicemia. Se reduce esa dosis (10–20 %, 2 a 4 UI); no se suspende ni se tocan ambas.

1.02.2.007 Síndrome hiperosmolar no cetósico

Diagnóstico: **Específico** · Tratamiento: **Inicial** · Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) · Tema 4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH · Tema 4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato · Tema 4.4 Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea · Tema 4.5 Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hiperosmolar no cetósico: DM2 de edad avanzada, deshidratación de días con compromiso de conciencia; glicemia >600 mg/dL, osmolaridad efectiva >320, sin acidosis ni cetosis significativa.
- Calcular osmolaridad efectiva 2×Na + glicemia/18 y sodio corregido Na + 1,6×(glicemia – 100)/100.
- Gatillantes: infecciones (n.º 1), IAM, ACV, corticoides, diuréticos, menor acceso al agua en adulto mayor.
- Manejo inicial: SF 0,9 % 1.000–1.500 mL la primera hora (bolos si shock); luego NaCl 0,45 % si Na corregido ≥135. Potasio según niveles. Insulina EV 0,1 UI/kg/h tras hidratar; SG 5 % cuando la glicemia llega a 300.
- Reponer 8–12 L en 24–48 h sin bajar la osmolaridad más de 3 mOsm/kg/h (edema cerebral); profilaxis de trombosis.
- Seguimiento: derivar; requiere hospitalización y luego control endocrinológico.

PREGUNTAS (5)

Pregunta de práctica

Hombre de 78 años con DM2 en tratamiento con metformina, traído por 5 días de poliuria, sed intensa y decaimiento, con escasa ingesta de líquidos. Está somnoliento pero responde, mucosas secas, PA 100/60 mmHg, FC 108 lpm. Glicemia 780 mg/dL, Na 146 mEq/L, nitrógeno ureico 58 mg/dL, pH 7,35, HCO3 21 mEq/L, cetonemia negativa. Osmolaridad efectiva calculada 336 mOsm/L. Potasio 4,6 mEq/L. **¿Cuál es la primera medida terapéutica?**

A) Bolo de insulina cristalina endovenosa de 0,1 UI/kg
B) Bicarbonato de sodio endovenoso
C) Suero glucosado al 5 %
D) Solución fisiológica al 0,9 % 1 a 1,5 litros en la primera hora
E) Suero hipotónico al 0,45 % en bolo rápido

Respuesta D. Estado hiperglicémico hiperosmolar: glicemia sobre 600 mg/dL, osmolaridad sobre 320 mOsm/L, sin cetosis ni acidosis importante. El déficit de agua es enorme, así que lo primero es solución fisiológica al 0,9 %. La insulina se inicia después de hidratar y con potasio sobre 3,3 mEq/L.

Pregunta de práctica

En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de 140 mEq/L, tras haber completado la reanimación inicial con 1.500 ml de solución salina al 0.9% en la primera hora. **¿Cuál es el fluido intravenoso de elección para la fase de mantenimiento?**

A) Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%)
B) Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)
C) Suero Glucosado al 10%
D) Ringer Lactato con bicarbonato
E) Agua destilada endovenosa pura sin electrolitos

Respuesta B. Na corregido = 140 + 1,6 × (900 – 100)/100 = 152,8 mEq/L. Con sodio corregido ≥ 135 hay déficit de agua libre: se usa NaCl 0,45% a 250–500 ml/h. El glucosado se agrega recién cuando la glicemia llega a ≤ 300 en el EHH.

Pregunta de práctica

Hombre de 74 años en tratamiento por estado hiperglicémico hiperosmolar (glicemia de ingreso 840 mg/dL, sin cetosis). Ya recibió la reposición inicial de volumen y está con NaCl 0,45 % e insulina cristalina en infusión endovenosa continua. K 4,2 mEq/L. A las 8 horas la glicemia es de 290 mg/dL, la osmolaridad efectiva 326 mOsm/L y aún está somnoliento. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Agregar suero glucosado al 5 % y reducir la infusión de insulina
B) Suspender la insulina hasta que la glicemia vuelva a subir
C) Mantener la misma infusión hasta lograr glicemia bajo 150 mg/dL
D) Pasar a insulina NPH subcutánea
E) Administrar un bolo de insulina para acelerar la corrección

Respuesta A. En el estado hiperosmolar, cuando la glicemia llega a 300 mg/dL se agrega suero glucosado al 5 % y se reduce la insulina a 0,02–0,05 UI/kg/h, manteniendo la glicemia entre 250 y 300 mg/dL hasta que la osmolaridad baje de 315 y el paciente esté lúcido. Así se evita una caída brusca de la osmolaridad.

Pregunta de práctica

Mujer de 76 años con DM2, hospitalizada hace 30 horas por estado hiperglicémico hiperosmolar, con insulina cristalina en infusión endovenosa y suero glucosado. Control actual: glicemia 240 mg/dL, Na 141 mEq/L, osmolaridad efectiva 309 mOsm/L, pH 7,38, K 4,0 mEq/L. Está lúcida, orientada como antes del cuadro, y pide comer. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener la infusión endovenosa hasta lograr glicemia bajo 140 mg/dL
B) Administrar insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa 1 a 2 horas más antes de suspenderla
C) Suspender la bomba y controlar con hemoglucotest sin insulina
D) Suspender la bomba y administrar solo insulina cristalina subcutánea según hemoglucotest
E) Mantener régimen cero y la infusión por 24 horas más

Respuesta B. El estado hiperosmolar está resuelto: osmolaridad efectiva bajo 315 mOsm/L, glicemia bajo 250–300 mg/dL y paciente lúcida que tolera la vía oral. Se pasa a insulina subcutánea traslapando: se inyecta la basal y la bomba se mantiene 1 a 2 horas, porque la insulina endovenosa dura solo minutos.

Pregunta de práctica

Hombre de 81 años, postrado, con DM2, hospitalizado por estado hiperglicémico hiperosmolar secundario a una neumonía: glicemia 920 mg/dL, osmolaridad efectiva 352 mOsm/L, sin cetosis. Se inicia hidratación con suero fisiológico, insulina en infusión endovenosa y antibióticos. Plaquetas 210.000/mm³, sin sangrado activo ni contraindicaciones.

Además del tratamiento indicado, ¿qué medida corresponde agregar?

A) Bicarbonato de sodio endovenoso
B) Fosfato de potasio endovenoso de rutina
C) Profilaxis de trombosis venosa con heparina de bajo peso molecular
D) Manitol profiláctico
E) Restricción de líquidos para evitar edema cerebral

Respuesta C. La deshidratación extrema, la hiperviscosidad y la inmovilidad hacen del estado hiperosmolar un cuadro con alto riesgo trombótico, tanto venoso como arterial. Se indica profilaxis con heparina de bajo peso molecular salvo contraindicación. El bicarbonato no se usa porque no hay acidosis, y el fosfato solo se repone si es menor de 1 mg/dL.

Conocimientos generales 14 códigos

1.02.3.001 Alimentación saludable

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Dieta saludable: predominio de verduras, frutas (5 porciones/día), legumbres, cereales integrales, pescado 2 veces/semana y lácteos descremados.
- Limitar sal (<5 g/día), azúcares libres (<10 % de las calorías), grasas saturadas y trans; evitar ultraprocesados y bebidas azucaradas. Preferir aceites vegetales y frutos secos.
- Ley de etiquetado chilena (sellos 'ALTO EN' calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio): preferir alimentos con menos sellos.
- Guías Alimentarias para Chile: agua 6–8 vasos/día, comer en familia, cocinar en casa.
- Combinar con actividad física: 150 min/semana de intensidad moderada en adultos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 35 años, sana, solicita orientación sobre alimentación saludable para su familia. **Según las Guías Alimentarias para la Población Chilena, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es correcta?**

A) Preferir jugos de fruta azucarados a la fruta entera
B) Consumir pescado solo una vez al mes
C) Consumir legumbres al menos 2 veces por semana
D) Consumir 1 porción de frutas y verduras al día
E) Evitar completamente los lácteos en adultos

Respuesta C. Las Guías Alimentarias chilenas recomiendan legumbres y pescado al menos 2 veces por semana, 5 porciones diarias de frutas y verduras de distintos colores, 3 porciones de lácteos bajos en grasa y azúcar, 6 a 8 vasos de agua y evitar alimentos con sellos 'ALTO EN'. La fruta entera se prefiere a los jugos.

1.02.3.002 Anorexia nerviosa

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios: restricción de la ingesta con peso significativamente bajo, miedo intenso a ganar peso y alteración de la imagen corporal. Subtipos restrictivo y con atracones/purgas.
- Típica en mujer adolescente; gravedad por IMC (leve ≥17, moderada 16–16,99, grave 15–15,99, extrema <15).
- Complicaciones: bradicardia, hipotensión, hipotermia, arritmias (QT largo), amenorrea hipotalámica, osteoporosis, lanugo, hipokalemia y alcalosis si purga.
- Hospitalizar ante inestabilidad (FC <40–50, hipotensión, alteraciones electrolíticas), IMC muy bajo o riesgo suicida; realimentación gradual por síndrome de realimentación (hipofosfemia).
- Tratamiento multidisciplinario: rehabilitación nutricional, psicoterapia (terapia familiar en adolescentes); los fármacos tienen rol menor. Derivar a psiquiatría.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 4

Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nerviosa desde hace 5 años, actualmente pesa 29 kg y mide 1,68 m, con IMC de 10,3 kg/m². **¿Con cuántas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?**

A) 300
B) 600
C) 1200
D) 1500
E) 2400

Respuesta A. Con desnutrición extrema (IMC bajo 12) el riesgo de síndrome de realimentación es muy alto: hipofosfemia, hipokalemia, hipomagnesemia, insuficiencia cardíaca y arritmias. Se inicia con un aporte bajo, alrededor de 10 kcal/kg/día (unas 300 kcal en 29 kg), con tiamina y control de electrolitos, y se aumenta progresivamente.

1.02.3.003 Diabetes y riesgo cardiovascular

Dónde se enseña: Tema 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular · Tema 2.3 Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4

QUÉ HAY QUE SABER

- La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el diabético; la DM con más de 10 años o con daño de órgano blanco es de riesgo alto o muy alto.
- El control glicémico protege sobre todo la microvasculatura; lo que más reduce eventos macrovasculares es controlar PA (<130/80), LDL (<70, o <55 si muy alto riesgo) y suspender el tabaco.
- Control glicémico agresivo (HbA1c <6 %, ACCORD) aumenta la mortalidad por hipoglicemias: metas individualizadas.
- Fármacos con beneficio cardiovascular: metformina (UKPDS), agonistas GLP-1 (liraglutida, semaglutida) en enfermedad aterosclerótica e iSGLT2 en insuficiencia cardíaca y ERC.
- Estatina en la mayoría de los diabéticos adultos; AAS en prevención secundaria. Ejercicio 150 min/semana.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con DM2 de 2 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 6,9 %. No fuma. Presión arterial 128/80 mmHg. Sin antecedentes de infarto ni ACV. Perfil lipídico: colesterol total 196 mg/dL, LDL 112 mg/dL, HDL 44 mg/dL, triglicéridos 180 mg/dL. Creatinina normal. **Según el Programa de Salud Cardiovascular del MINSAL, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a su riesgo cardiovascular?**

A) No requiere estatina, porque su LDL es menor de 130 mg/dL
B) Calcular el riesgo con tablas y repetir perfil lipídico en un año
C) Iniciar gemfibrozilo por la hipertrigliceridemia
D) Iniciar aspirina 100 mg/día como prevención primaria
E) Iniciar atorvastatina, porque la diabetes lo clasifica como alto riesgo cardiovascular

Respuesta E. En el Programa de Salud Cardiovascular, la persona con diabetes mayor de 40 años se clasifica directamente como alto riesgo cardiovascular, sin necesidad de tablas, y se le indica estatina independiente del LDL. La aspirina no se indica de rutina en prevención primaria.

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de 32%, con disnea de esfuerzo CF II. HbA1c 8,2%. VFG 62 mL/min. Se decide asociar un segundo fármaco. **¿Cuál es el segundo fármaco de elección?**

A) Glibenclamida
B) Pioglitazona
C) Empagliflozina o dapagliflozina
D) Sitagliptina
E) Insulina NPH nocturna

Respuesta C. DM2 con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida: el segundo fármaco de elección es un iSGLT2, que reduce en más de 30% las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frena el deterioro renal, sin hipoglicemias. La pioglitazona retiene líquido y está contraindicada.

1.02.3.004 Estilos de vida saludables (hábitos y conductas)

Dónde se enseña: Tema 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Pilares: alimentación saludable, actividad física regular, no fumar, consumo de alcohol bajo riesgo, sueño adecuado y manejo del estrés.
- Actividad física: 150 min/semana aeróbica moderada (caminar rápido, nadar, bicicleta) en al menos 3 días, sin más de 2 días seguidos de inactividad, y fuerza 2–3 veces/semana.
- El ejercicio aumenta la captación de glucosa por GLUT-4 sin insulina; baja HbA1c 0,5–1 % y la sensibilidad dura 24–48 h.
- En usuarios de insulina o glibenclamida: glicemia <100 antes del ejercicio requiere colación de 15–20 g; >250 con cetonas, no hacer ejercicio. Neuropatía: natación o bicicleta; retinopatía proliferativa: evitar Valsalva.
- Consejería breve en cada control (modelo de etapas de cambio); programas chilenos como Elige Vivir Sano y Vida Sana.

Sin pregunta

1.02.3.005 Prevención de complicaciones crónicas de la diabetes

Dónde se enseña: Tema 1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

QUÉ HAY QUE SABER

- Control metabólico individualizado: HbA1c <7 % previene complicaciones microvasculares; PA <130/80 y LDL <70 previenen las macrovasculares.
- Tamizaje anual desde el diagnóstico en DM2 (DM1 desde los 5 años): RAC en orina matinal y creatinina, fondo de ojo o retinografía, examen de pies con monofilamento.
- Albuminuria confirmada: IECA o ARA-II aunque sea normotenso, + iSGLT2. Retinopatía: derivar a oftalmología.
- Pie: educación, calzado adecuado, inspección diaria, podología; clasificar riesgo con monofilamento y pulsos.
- Suspender tabaco, estatina según riesgo, vacunación (influenza, neumococo) y evitar nefrotóxicos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con DM2 de 6 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 7,2 %. Presión arterial 126/78 mmHg. En su control anual se detecta una razón albúmina/creatinina urinaria de 85 mg/g, que se confirma en una segunda muestra 2 meses después. Creatinina 0,9 mg/dL, VFG 88 mL/min. **¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la progresión de la nefropatía?**

A) Cambiar la metformina por glibenclamida
B) Restringir las proteínas a 0,4 g/kg/día
C) Iniciar enalapril o losartán
D) Controlar la albuminuria en un año, ya que la presión es normal
E) Agregar amlodipino

Respuesta C. Albuminuria moderadamente elevada confirmada (30–300 mg/g) en diabético: se indica IECA o ARA II aunque la presión sea normal, porque reducen la albuminuria y retrasan la nefropatía. La restricción proteica extrema no se recomienda y el amlodipino no tiene efecto antiproteinúrico.

1.02.3.006 Prevención de Diabetes Mellitus tipo 2

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizar con glicemia de ayuno a quien tenga IMC ≥25 + 1 factor de riesgo o ≥45 años; normal (<100) repetir cada 3 años.
- Prediabetes: glicemia de ayuno 100–125, PTGO 2 h 140–199 o HbA1c 5,7–6,4 %. Ayuno 100–125 se estudia con PTGO.
- Intervención más eficaz: estilo de vida, con baja de 5–7 % del peso y 150 min/semana de actividad física (reduce cerca de 58 % la progresión, DPP).
- Metformina como segunda línea en alto riesgo (ITG con IMC >35, menores de 60 años, DMG previa).
- Grupos de riesgo: antecedente familiar, DMG previa, SOP, síndrome metabólico, acantosis nigricans. Mujer con DMG: PTGO posparto.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 30

Hombre de 48 años con glicemia de ayuno de 115 mg/dL en dos ocasiones. IMC 28. Sin otros factores de riesgo. **¿Cuál es la intervención más importante para reducir la progresión a diabetes?**

A) Dieta estricta baja en carbohidratos
B) Metformina 500 mg dos veces al día
C) Ejercicio aeróbico 150 minutos por semana
D) Orlistat
E) Insulina basal

Respuesta C. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL: prediabetes. La intervención más efectiva para frenar la progresión a diabetes es el cambio de estilo de vida, con ejercicio aeróbico de intensidad moderada de al menos 150 minutos por semana, más dieta saludable.

1.02.3.007 Prevención de dislipidemias

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje con perfil lipídico en el examen de medicina preventiva y en el PSCV; antes en antecedente familiar de hipercolesterolemia o enfermedad coronaria precoz.
- Estimar riesgo cardiovascular global para definir la meta de LDL e indicar estatina.
- Dieta: reducir grasas saturadas (<7–10 % de las calorías) y eliminar grasas trans; aumentar fibra soluble, pescado y aceites vegetales; limitar azúcares simples y alcohol (bajan TG).
- Actividad física regular, mantener peso saludable y no fumar (sube HDL).
- Hipercolesterolemia familiar (LDL ≥190): tamizaje en cascada de familiares de primer grado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 42 años, con colesterol LDL de 145 mg/dL, sin otros factores de riesgo y con riesgo cardiovascular bajo, pregunta qué cambio alimentario reduce más su LDL. **¿Cuál es la medida dietética más efectiva para reducir el colesterol LDL?**

A) Suprimir todas las grasas, incluidos el aceite de oliva y los frutos secos
B) Eliminar completamente los huevos
C) Aumentar el consumo de azúcares simples
D) Consumir más carnes rojas procesadas
E) Reducir las grasas saturadas y trans, reemplazándolas por grasas insaturadas

Respuesta E. Las grasas saturadas (carnes grasas, mantequilla, embutidos) y trans son los principales determinantes dietéticos del LDL. Reemplazarlas por grasas insaturadas (aceite de oliva o canola, frutos secos, pescado), sumando fibra soluble y actividad física, es la base de la prevención. El colesterol del huevo influye menos.

1.02.3.008 Prevención de la obesidad

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- En niños: menor de 5 años usar Peso/Talla y de 5 a 19 años IMC/Edad; sobrepeso +1 a +2 DE, obesidad >+2 DE, obesidad severa ≥+3 DE.
- Prevención desde la gestación y la infancia: lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, alimentación complementaria sin azúcar añadida, evitar jugos y bebidas azucaradas.
- Sobrepeso u obesidad infantil: sin dietas restrictivas (nunca bajo 2 años); eliminar azúcar y ultraprocesados y aumentar el juego activo diario; la meta es que la talla alcance al peso.
- Limitar pantallas, promover actividad física diaria (60 min en niños) y sueño adecuado.
- Políticas chilenas: Ley de etiquetado (sellos), programa Elige Vivir Sano, Vida Sana; controles de salud con antropometría seriada.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de salud de un niño de 4 años, el IMC está en percentil 80 (normal). Los padres refieren que toma bebidas azucaradas a diario y ve pantallas 4 horas al día. **¿Cuál es la intervención preventiva más adecuada?**

A) Indicar una dieta hipocalórica estricta
B) Consejería familiar: reemplazar bebidas azucaradas por agua, limitar pantallas a 1 hora diaria y promover juego activo diario
C) Iniciar metformina
D) Derivar a cirugía
E) No intervenir, porque aún no tiene sobrepeso

Respuesta B. La prevención de la obesidad infantil se basa en cambiar hábitos de toda la familia: agua en vez de bebidas azucaradas, frutas y verduras, comidas en familia, al menos 60 minutos diarios de actividad física y limitar pantallas (máximo 1 hora en preescolares). Esperar el sobrepeso pierde la oportunidad preventiva; las dietas restrictivas no se indican en niños.

1.02.3.009 Prevención de pié diabético

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen anual de pies en el PSCV: monofilamento 10 g (un punto no percibido = alto riesgo), diapasón 128 Hz, pulsos pedio y tibial posterior; si faltan, índice tobillo-brazo.
- Clasificar el riesgo de ulceración y ajustar la frecuencia de control según el riesgo.
- Educación: inspección diaria de los pies (espejo), lavado y secado entre los dedos, hidratación sin crema interdigital, corte recto de uñas, no caminar descalzo ni usar guateros.
- Calzado acolchado sin costuras internas, podología para callosidades y uñas; plantillas de descarga en deformidades.
- Control de glicemia, PA y lípidos, suspender tabaco; consultar precozmente ante cualquier lesión.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de una mujer de 60 años con DM2 de 12 años de evolución, el examen con monofilamento de 10 g muestra pérdida de sensibilidad en ambos pies. No tiene úlceras ni deformidades y los pulsos son normales. **¿Cuál es la medida preventiva más adecuada?**

A) Indicar caminar descalza para fortalecer los pies
B) Educación en autocuidado con inspección diaria de los pies, calzado adecuado y control podológico periódico
C) Remojar los pies en agua caliente diariamente
D) Amputación profiláctica de ortejos
E) Controlar los pies solo si aparece una úlcera

Respuesta B. La pérdida de sensibilidad protectora al monofilamento aumenta el riesgo de ulceración. Se indica educación (inspección diaria, secado entre ortejos, no andar descalza, no remojar en agua caliente), calzado adecuado, podología y controles periódicos. Todo diabético debe tener evaluación de riesgo de pie al menos una vez al año.

1.02.3.010 Regímenes dietéticos fundamentales

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Régimen común (normal): balanceado, 50–60 % carbohidratos, 15–20 % proteínas y 25–30 % grasas; base para los demás.
- Por consistencia: líquido (claro o completo), papilla, blando y liviano; se progresa según tolerancia (postoperatorio, disfagia, adulto mayor).
- Hiposódico (<2 g de sodio en HTA, IC, cirrosis con ascitis), hipograso (colelitiasis, pancreatitis), sin residuo (preparación de colonoscopia, diarrea aguda) y rico en fibra (constipación, diverticulosis).
- Diabético: fraccionado, carbohidratos complejos de bajo índice glicémico, sin azúcares simples. Renal: control de proteínas, potasio, fósforo y sodio según etapa.
- Sin gluten de por vida en enfermedad celíaca; sin lactosa en intolerancia. En la cirrosis no se restringen las proteínas (1,2–1,5 g/kg/día) salvo encefalopatía refractaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 58 años con cirrosis hepática por alcohol presenta ascitis moderada, sin encefalopatía. Su natremia es 136 mEq/L. **¿Cuál es el régimen dietético más adecuado?**

A) Restricción hídrica bajo 500 mL/día
B) Restricción proteica estricta, bajo 0,5 g/kg/día
C) Régimen hiposódico (unos 2 g de sodio al día) con aporte proteico normal
D) Régimen hipersódico para expandir el volumen
E) Ayuno hasta resolver la ascitis

Respuesta C. En la ascitis cirrótica el pilar dietético es la restricción de sodio (unos 2 g de sodio, o 5 g de sal, al día) junto a diuréticos. El aporte proteico debe ser normal (1,2-1,5 g/kg/día), porque suelen estar desnutridos; la restricción proteica ya no se recomienda. La restricción hídrica solo se indica con natremia bajo 125 mEq/L.

1.02.3.011 Regímenes dietéticos para dislipidemias

Dónde se enseña: Tema 5.5 Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipercolesterolemia: reducir grasas saturadas (<7 % de las calorías) y eliminar grasas trans; colesterol dietario bajo; preferir aceites vegetales, pescado, legumbres y fibra soluble (avena).
- Hipertrigliceridemia: eliminar alcohol y azúcares simples/fructosa, reducir carbohidratos refinados y bajar de peso.
- TG ≥500–1.000 mg/dL: dieta casi sin grasa (<15–20 % de las calorías), cero alcohol y sin azúcares simples, además de fibrato.
- Dieta mediterránea y ejercicio aeróbico regular complementan; omega-3 de pescado ayuda a bajar TG.
- La dieta sola rara vez alcanza la meta de LDL en riesgo alto; no retrasa el inicio de estatina cuando está indicada.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 46 años, obeso, consume 4 a 5 latas de cerveza diarias y bebidas azucaradas. Su perfil lipídico muestra triglicéridos de 650 mg/dL y LDL de 110 mg/dL. No tiene antecedente de pancreatitis. **Además del tratamiento farmacológico, ¿cuál es la medida dietética más importante?**

A) Aumentar el consumo de pan blanco
B) Aumentar el consumo de jugos de fruta
C) Dieta rica en grasas saturadas y baja en proteínas
D) Eliminar exclusivamente el huevo
E) Suspender el alcohol y reducir azúcares simples y carbohidratos refinados

Respuesta E. La hipertrigliceridemia responde especialmente a suprimir el alcohol, reducir azúcares simples (bebidas, jugos, dulces) y carbohidratos refinados, bajar de peso y hacer ejercicio. Con triglicéridos sobre 500 mg/dL se agrega fibrato por riesgo de pancreatitis, y sobre 1.000 mg/dL, restricción estricta de grasas. El huevo influye poco.

1.02.3.012 Regímenes dietéticos para obesidad

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Base: déficit de 500–1.000 kcal/día para bajar 0,5–1 kg/semana; meta inicial 5–10 % del peso en 6 meses.
- Distribución balanceada (dieta mediterránea o hipocalórica equilibrada); restringir azúcares simples, bebidas azucaradas, alcohol y ultraprocesados.
- Dietas muy bajas en calorías (<800 kcal) solo bajo supervisión médica; las dietas de moda no son superiores a largo plazo.
- Combinar con 150–300 min/semana de actividad física y terapia conductual para mantener la baja de peso.
- En diabéticos con insulina o sulfonilureas ajustar dosis al reducir la ingesta (riesgo de hipoglicemia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 45 años, con IMC de 32 kg/m², desea bajar de peso. Su gasto energético estimado es de 2.000 kcal/día. **¿Cuál es la prescripción dietética más adecuada para iniciar?**

A) Dieta de 600 kcal/día sin supervisión
B) Ayuno total por 2 semanas
C) Dieta libre de carbohidratos en forma indefinida
D) Dieta con déficit de 500 a 750 kcal/día respecto de su gasto, balanceada y sostenible
E) Mantener la ingesta y agregar diuréticos

Respuesta D. Un déficit de 500 a 750 kcal/día (unas 1.200-1.500 kcal en mujeres) produce una baja de 0,5 a 1 kg por semana. La meta inicial es bajar 5 a 10% del peso en 6 meses, lo que ya mejora presión, glicemia y lípidos. Lo clave es la adherencia; las dietas de muy bajo aporte requieren supervisión estricta.

1.02.3.013 Riesgo cardiovascular global

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Riesgo cardiovascular global: probabilidad de evento a 10 años según varios factores (edad, sexo, PA, colesterol, tabaco, diabetes); en Chile se usa la tabla de Framingham adaptada.
- Riesgo muy alto sin calcular: evento ateroesclerótico previo (IAM, ACV, AIT, arteriopatía periférica), DM con daño de órgano blanco o VFG <45.
- Alto: DM >10 años sin daño, HTA ≥160/100, ERC 3a o Framingham 10–19 %; moderado: DM <10 años o Framingham 5–9 %; bajo: <5 %.
- El riesgo define la meta de LDL (<55–70 muy alto, <70 alto, <100 moderado) y la intensidad de la estatina.
- Se evalúa en el EMPA y el PSCV; manejar todos los factores juntos, no un número aislado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 46 años, no fumadora, sin diabetes, consulta en el CESFAM para ingresar al Programa de Salud Cardiovascular. En 3 controles distintos tiene presión arterial promedio de 166/104 mmHg. Perfil lipídico: colesterol total 205 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 128 mg/dL. Creatinina 0,7 mg/dL, sin albuminuria. **Según el MINSAL, ¿cómo se clasifica su riesgo cardiovascular?**

A) Bajo, porque es mujer menor de 50 años y no fuma
B) Moderado, según las tablas de Framingham adaptadas a Chile
C) No se puede clasificar sin una prueba de esfuerzo
D) Alto, directamente, sin necesidad de usar tablas, por presión arterial de 160/100 mmHg o más
E) Alto solo si el LDL supera 190 mg/dL

Respuesta D. En el Programa de Salud Cardiovascular algunas condiciones clasifican directamente como alto riesgo, sin tablas: enfermedad cardiovascular previa, diabetes, ERC etapa 3b o más, LDL 190 mg/dL o más y presión arterial persistente de 160/100 mmHg o más. En los demás se usa la tabla de Framingham adaptada a Chile.

1.02.3.014 Síndrome metabólico

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjunto de factores de riesgo ligados a resistencia a la insulina y obesidad abdominal; 3 de 5: cintura aumentada, PA ≥130/85, glicemia ≥100, TG ≥150, HDL bajo.
- Duplica el riesgo cardiovascular y aumenta mucho el riesgo de DM2.
- Prevención: alimentación saludable, actividad física 150 min/semana y mantener peso y cintura normales.
- Detección en el EMPA midiendo cintura, PA, glicemia y perfil lipídico; acantosis nigricans y acrocordones son pistas clínicas.
- El cambio de estilo de vida es el tratamiento de primera línea; tratar cada componente fuera de meta.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 50 años tiene diagnóstico de síndrome metabólico: cintura de 104 cm, triglicéridos 180 mg/dL, HDL 38 mg/dL y glicemia de ayuno 110 mg/dL. Su presión arterial es 128/82 mmHg. **¿Cuál es la intervención de primera línea?**

A) Metformina, fenofibrato y losartán desde el inicio
B) Cambios de estilo de vida, con meta de bajar 5 a 10% del peso, dieta saludable y actividad física
C) Cirugía bariátrica
D) Insulina NPH nocturna
E) Control anual sin intervención

Respuesta B. El tratamiento de primera línea del síndrome metabólico es el cambio de estilo de vida: bajar 5 a 10% del peso, dieta saludable, al menos 150 minutos semanales de actividad física y no fumar. Esto mejora todos sus componentes a la vez. Los fármacos se agregan según cada componente que lo requiera, no por el diagnóstico.

Exámenes e imagenología 25 códigos

1.02.4.001 Arteriografia extremidades inferiores

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Estándar anatómico de la enfermedad arterial periférica: muestra sitio, extensión de estenosis/oclusiones y lecho distal; se pide para planificar revascularización.
- Indicación: isquemia crítica (dolor de reposo, úlcera, gangrena), claudicación invalidante o isquemia aguda, generalmente tras eco-Doppler; la angio-TAC o angio-RM son alternativas menos invasivas.
- En el diabético el compromiso típico es infrapoplíteo (tibiales y peronea), con calcificación difusa.
- Riesgos: nefropatía por contraste (frecuente en diabéticos con ERC), hematoma o pseudoaneurisma en el sitio de punción, alergia al contraste.
- Antes del examen: hidratar, suspender metformina 48 h y controlar creatinina; el médico general emplea el informe para derivar a cirugía vascular.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 70 años, diabético, presenta dolor en reposo en el pie derecho que lo despierta en la noche y una úlcera en el primer ortejo que no cicatriza hace 6 semanas. No tiene pulsos poplíteo ni pedio derechos y el índice tobillo-brazo es 0,3. **¿Cuál es el examen más adecuado para planificar el tratamiento?**

A) Arteriografía (o angioTAC) de extremidades inferiores
B) Radiografía de pie
C) Electromiografía
D) Cintigrama óseo
E) Repetir el índice tobillo-brazo en 6 meses

Respuesta A. Dolor de reposo y úlcera que no cicatriza con ITB muy bajo es isquemia crítica de la extremidad, con alto riesgo de amputación. Requiere estudio anatómico arterial (arteriografía o angioTAC) para planificar la revascularización endovascular o quirúrgica; la arteriografía además puede ser terapéutica (angioplastía). Esperar implica perder la extremidad.

1.02.4.002 Ecotomografia abdominal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de primera línea, barato y sin radiación, para hígado, vía biliar, páncreas, bazo, riñones y aorta abdominal.
- Hígado graso: hígado hiperecogénico ('brillante'); cirrosis: bordes nodulares, hipertrofia del lóbulo caudado, esplenomegalia, ascitis.
- Vía biliar: de elección en colelitiasis (imagen hiperecogénica con sombra acústica) y para medir dilatación de la vía biliar (colédoco >6 mm).

- Útil en tamizaje semestral de hepatocarcinoma en cirróticos y para caracterizar masas hepáticas iniciales.
- Limitaciones: obesidad y gas intestinal; páncreas a menudo mal visualizado (TAC si sospecha tumor o complicación).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un hombre de 48 años, con IMC de 33 kg/m², DM2 y triglicéridos elevados, tiene transaminasas 1,5 veces sobre lo normal en un control. No consume alcohol y las serologías de hepatitis B y C son negativas. **¿Cuál es el examen de imagen inicial más adecuado?**
>
> **A)** Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
> **B)** Colangiorresonancia
> **C)** TAC de abdomen con contraste
> **D)** Biopsia hepática de entrada
> **E)** Ecotomografía abdominal
>
> Respuesta E. Se sospecha enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. La ecotomografía abdominal es el examen inicial: barata, sin radiación, muestra el hígado hiperecogénico (esteatosis) y descarta otras causas. Luego se estima fibrosis con FIB-4 o elastografía. La biopsia se reserva para casos dudosos o sospecha de fibrosis avanzada.

1.02.4.003 Albúmina plasmática

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Valor normal 3,5–5 g/dL; vida media de ~20 días, refleja estado nutricional y síntesis hepática de semanas.
- Hipoalbuminemia: desnutrición crónica, cirrosis (síntesis), síndrome nefrótico (<3 g/dL con proteinuria >3,5 g/24 h), enteropatía perdedora de proteínas, inflamación aguda (reactante de fase negativo).
- Es parte del Child-Pugh y predictor de mortalidad y complicaciones postoperatorias; <3 g/dL indica riesgo nutricional.
- En inflamación aguda baja aunque no haya desnutrición: interpretar con la clínica y la PCR; la prealbúmina refleja cambios recientes (vida media 2 días).
- Corrección del calcio: Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 – albúmina).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un hombre de 68 años será operado de una colectomía electiva. Ha bajado 10% de su peso en 3 meses. En el preoperatorio, su albúmina plasmática es 2,6 g/dL, sin proteinuria ni daño hepático. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**
>
> **A)** La albúmina es normal y se opera sin cambios
> **B)** La albúmina refleja cambios nutricionales en 24 horas
> **C)** La albúmina baja indica deshidratación y basta con hidratar
> **D)** Es un marcador de desnutrición y de mayor riesgo de complicaciones: optimizar el estado nutricional antes de la cirugía
> **E)** Indicar infusión de albúmina como tratamiento nutricional
>
> Respuesta D. La hipoalbuminemia sin pérdidas renales ni daño hepático, junto a baja de peso, indica desnutrición y se asocia a más dehiscencias, infecciones y mortalidad postoperatoria. Se recomienda soporte nutricional por 7 a 14 días antes de una cirugía electiva. La albúmina tiene vida media de unos 20 días y su infusión no nutre.

1.02.4.004 Relación albuminuria / creatininuria

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección para tamizar nefropatía diabética: en muestra aislada de primera orina matinal, expresado en mg/g.
- Categorías KDIGO: A1 <30 mg/g normal; A2 30–299 (antigua microalbuminuria); A3 ≥300 mg/g.
- Confirmar con 2 de 3 muestras alteradas en 3–6 meses; falsos positivos por ITU, fiebre, ejercicio intenso, hematuria, IC descompensada o hiperglicemia marcada.

- Tamizaje anual: DM2 desde el diagnóstico, DM1 a los 5 años del debut, y en hipertensos.
- RAC ≥30 confirmada: IECA o ARA-II aunque sea normotenso, + iSGLT2; A3: dosis máxima y derivar a nefrología.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 61 años con DM2 de 9 años de evolución, PA 126/78 mmHg, sin albuminuria en controles previos. En su control anual se solicita razón albúmina/creatinina urinaria (RAC) en orina matinal: 140 mg/g. Ese día refiere disuria, polaquiuria y fiebre de 38,2 °C desde hace 2 días; el sedimento urinario muestra abundantes leucocitos y bacterias. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la RAC?**
>
> **A)** Iniciar losartán por albuminuria moderadamente elevada
> **B)** Derivar a nefrología por nefropatía diabética
> **C)** Solicitar orina de 24 horas para proteinuria
> **D)** Tratar la infección urinaria y repetir la RAC una vez resuelta
> **E)** Suspender la metformina por daño renal
>
> Respuesta D. La RAC en orina matinal aislada es el examen de tamizaje de la nefropatía diabética, pero se eleva transitoriamente con infección urinaria, fiebre, ejercicio intenso, hiperglicemia marcada o insuficiencia cardíaca descompensada. Se trata la infección y se repite la RAC; solo 2 de 3 muestras alteradas confirman albuminuria.

1.02.4.005 Creatininemia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Marcador de filtración glomerular; depende de la masa muscular (baja en adulto mayor, mujeres y desnutridos, puede ocultar ERC).
- Siempre estimar VFG con fórmula (CKD-EPI); ERC si VFG <60 mL/min/1,73 m² por más de 3 meses, etapificar G1–G5.
- Aumento agudo: injuria renal aguda (alza ≥0,3 mg/dL en 48 h o ≥1,5 veces la basal); diferenciar prerrenal, renal y posrenal.
- Guía el ajuste de fármacos: metformina (máx. 1.000 mg si VFG 30–44, suspender <30), antibióticos, contraste yodado.
- Al iniciar IECA/ARA-II se acepta alza de creatinina de hasta 30 %; mayor obliga a buscar estenosis renal o hipovolemia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Una mujer de 84 años, de 45 kg y con sarcopenia, tiene creatinina plasmática de 1,0 mg/dL. Se calcula su velocidad de filtración glomerular estimada (VFGe) en 50 mL/min/1,73 m². **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
>
> **A)** Tiene disminución de la función renal, que la creatinina sola subestima por su baja masa muscular
> **B)** Su función renal es normal, porque la creatinina está en rango normal
> **C)** La creatinina sobreestima el daño renal en los adultos mayores
> **D)** Debe medirse solo la creatinina en orina de 24 horas
> **E)** La VFGe no es aplicable en mayores de 70 años
>
> Respuesta A. La creatinina depende de la masa muscular: en adultos mayores con poca masa muscular, una creatinina normal puede ocultar una VFG disminuida. Por eso se usa la VFG estimada (CKD-EPI), que ajusta por edad y sexo. Es clave para ajustar dosis de fármacos y para etapificar la enfermedad renal crónica.

1.02.4.006 Cuerpos cetónicos en orina (semicuantitativo)

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

QUÉ HAY QUE SABER

- Tira reactiva que detecta acetoacetato (no el β-hidroxibutirato, el cetoácido predominante en la CAD), por lo que puede subestimar la cetosis.

- Indicación: DM1 con glicemia >250 mg/dL, enfermedad intercurrente, vómitos o dolor abdominal; antes del ejercicio si glicemia >250.
- Interpretación: negativa o trazas tranquiliza; ++ o más con hiperglicemia obliga a descartar cetoacidosis con gases y electrolitos.
- Falsos positivos por ayuno prolongado, embarazo o dieta cetogénica; en la recuperación de la CAD puede seguir positiva aunque el paciente mejore (no sirve para seguir la resolución).
- Técnica: orina fresca, tira no vencida, leer al tiempo indicado por el fabricante.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un paciente de 25 años con DM1 ingresa con vómitos, dolor abdominal y respiración de Kussmaul. Glicemia 480 mg/dL, pH 7,10, bicarbonato 8 mEq/L y anión gap de 24. La cetonuria con tira reactiva (nitroprusiato) es solo débilmente positiva (+). **¿Cuál es la explicación más probable de la cetonuria débil?**
>
> **A)** Descarta una cetoacidosis diabética
> **B)** Indica un estado hiperosmolar puro
> **C)** La tira detecta acetoacetato y acetona, pero no el beta-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis
> **D)** Se debe a que la glicemia es muy alta
> **E)** Indica exclusivamente acidosis láctica
>
> Respuesta C. El nitroprusiato detecta acetoacetato y acetona, no beta-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis grave. Por eso la cetonuria puede subestimar la cetosis y se prefiere medir beta-hidroxibutirato en sangre. Con acidosis metabólica de anión gap alto e hiperglicemia, el diagnóstico de cetoacidosis se mantiene.

1.02.4.007 Cuerpos cetónicos en sangre

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

QUÉ HAY QUE SABER

- Mide β-hidroxibutirato capilar o plasmático, el cuerpo cetónico predominante en la cetoacidosis; más exacto que la cetonuria.
- Valores: <0,6 mmol/L normal; 0,6–1,5 cetosis leve; 1,5–3 riesgo de CAD; >3 mmol/L compatible con CAD junto a acidosis.
- Útil para diagnosticar CAD euglicémica en usuarios de iSGLT2 (glicemia <250 con acidosis y gap alto).
- Seguimiento de la resolución: cetonemia <0,6 mmol/L o en franco descenso, junto con pH, bicarbonato y anion gap.
- En hiperglicemia grave sin cetonemia significativa pensar en estado hiperosmolar.

Sin pregunta

1.02.4.008 Doppler vascular periférico

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen no invasivo de elección inicial para evaluar enfermedad arterial periférica y venosa (trombosis venosa profunda).
- Arterial: localiza estenosis y oclusiones y mide velocidades; complementa al índice tobillo-brazo (<0,9 anormal), que en diabéticos puede ser falsamente alto (>1,3) por calcificación.
- Indicado ante pulsos ausentes, claudicación, úlcera isquémica o gangrena, y antes de amputar o resecar tejido en pie diabético.
- Venoso: incompresibilidad de la vena = TVP; útil en insuficiencia venosa crónica.
- Operador dependiente; si muestra lesión revascularizable se completa con angio-TAC o arteriografía. El médico general emplea el informe para derivar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 72 años, con DM2 de 20 años y enfermedad renal crónica, refiere claudicación de pantorrillas. Sus pulsos pedios son débiles, pero el índice tobillo-brazo resulta 1,5. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Descartar enfermedad arterial, porque el índice es normal
B) Solicitar electromiografía
C) Indicar amputación
D) Considerar el índice no confiable por calcificación arterial y realizar ecografía Doppler arterial o índice dedo-brazo
E) Repetir el mismo índice en 1 año

Respuesta D. Un ITB sobre 1,3-1,4 indica arterias no compresibles por calcificación de la media, frecuente en diabéticos y en enfermedad renal, y no es confiable. Con claudicación y pulsos débiles se estudia con ecografía Doppler arterial (morfología de onda, estenosis) o índice dedo-brazo, porque las arterias digitales suelen respetarse.

1.02.4.009 Electrocardiograma

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: 12 derivaciones, paciente en reposo, electrodos precordiales V1–V6 bien ubicados; velocidad 25 mm/s.
- En el diabético: la isquemia puede ser silente (neuropatía autonómica); buscar ondas Q, alteraciones del ST-T y bloqueos en el control basal.
- Hipokalemia (en tratamiento de CAD con insulina): T aplanada, ST descendido y onda U prominente; arritmias ventriculares.
- Hiperkalemia: T alta y picuda, PR largo, QRS ancho, ritmo sinusoidal; urgencia (gluconato de calcio).
- ECG en todo diabético al ingreso al PSCV y periódicamente; en CAD/EHH monitorizar ritmo mientras se repone potasio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un paciente de 30 años con DM1 ingresa con cetoacidosis diabética: glicemia 520 mg/dL, pH 7,08 y bicarbonato 6 mEq/L. Se inicia hidratación con suero fisiológico. El potasio aún no está disponible, pero el ECG muestra ondas T aplanadas, depresión del ST y ondas U prominentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la insulina?**

A) Postergar la insulina y reponer potasio, porque el ECG sugiere hipokalemia
B) Iniciar insulina en bolo inmediatamente
C) Administrar bicarbonato antes de todo
D) Administrar gluconato de calcio por hiperkalemia
E) Iniciar insulina subcutánea

Respuesta A. Ondas T aplanadas, depresión del ST y ondas U sugieren hipokalemia. La insulina introduce potasio a las células y puede precipitar arritmias graves. Mientras llega el potasio, el ECG orienta: si sugiere hipokalemia (o K bajo 3,3 mEq/L) se repone potasio antes de iniciar insulina. Las T picudas sugerirían hiperkalemia.

1.02.4.010 Electromiografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudia la conducción nerviosa y la actividad muscular; diferencia neuropatía axonal de desmielinizante y localiza atrapamientos.
- Indicación: neuropatía atípica (asimétrica, motora predominante, rápidamente progresiva), sospecha de túnel carpiano antes de cirugía, radiculopatía o miopatía.
- No se usa para el tamizaje de la neuropatía diabética, que se hace con monofilamento de 10 g anual.
- En polineuropatía diabética: patrón axonal sensitivo-motor distal y simétrico; túnel carpiano: latencia distal del mediano prolongada en la muñeca.
- El médico general emplea el informe para confirmar el diagnóstico y derivar (neurología, cirugía de mano).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 52 años, diabética, refiere parestesias nocturnas en el pulgar, índice y medio de la mano derecha que la despiertan y mejoran al sacudir la mano. Tiene signos de Phalen y Tinel positivos y leve atrofia tenar. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y evaluar su severidad?**

A) Radiografía de muñeca
B) Ecocardiograma
C) RM de columna cervical
D) Hemoglobina glicosilada
E) Electromiografía con velocidad de conducción nerviosa

Respuesta E. El cuadro es un síndrome del túnel carpiano (atrapamiento del nervio mediano), más frecuente en diabéticos. La electromiografía con estudio de conducción nerviosa confirma la lesión, mide su severidad y la diferencia de una radiculopatía C6-C7 o de la polineuropatía diabética. Con atrofia tenar, la indicación es quirúrgica.

1.02.4.011 Estudio funcional hepático

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Patrón hepatocelular: transaminasas elevadas (ALT predominante en virus/NASH); AST/ALT >2 con GGT y VCM altos sugiere alcohol; >1.000 UI/L: virus, fármacos (paracetamol) o isquemia.
- Patrón colestásico: FA y GGT elevadas con o sin bilirrubina directa; estudiar vía biliar con ecografía.
- Función de síntesis: tiempo de protrombina/INR (el mejor marcador de gravedad en la hepatitis aguda y criterio de derivación a trasplante) y albúmina.
- En el diabético con transaminasas levemente elevadas: pensar en hígado graso metabólico (AST/ALT <1, ecografía con hígado brillante).
- Antes de iniciar estatinas y en seguimiento de fármacos hepatotóxicos; la elevación leve de transaminasas no contraindica las estatinas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 50 años, que bebe 6 vasos de vino diarios, tiene GOT 180 U/L, GPT 70 U/L, GGT 420 U/L, bilirrubina 1,2 mg/dL y tiempo de protrombina 85%. No usa fármacos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis viral aguda
B) Coledocolitiasis
C) Daño hepático por alcohol
D) Hepatitis autoinmune
E) Hemocromatosis

Respuesta C. Una relación GOT/GPT mayor de 2, con transaminasas bajo 300 U/L y GGT muy elevada, es el patrón típico del daño hepático alcohólico. La hepatitis viral aguda suele dar transaminasas sobre 1.000 U/L con predominio de GPT, y la coledocolitiasis da un patrón colestásico con fosfatasa alcalina alta y dolor.

1.02.4.012 Evaluación nutricional

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Antropometría: IMC (bajo peso <18,5; sobrepeso 25–29,9; obesidad ≥30; en adulto mayor normal 23–28), circunferencia de cintura y de pantorrilla, pliegues.
- Historia: ingesta (encuesta de 24 h), baja de peso involuntaria (>5 % en 1 mes o >10 % en 6 meses es significativa), síntomas digestivos y capacidad funcional.
- Herramientas de tamizaje: valoración global subjetiva (VGS), MNA en adulto mayor (<17 desnutrición, 17–23,5 riesgo), NRS-2002 en hospitalizados.
- Laboratorio: albúmina (crónica), prealbúmina (aguda), recuento de linfocitos, colesterol; balance nitrogenado para el catabolismo.

- En niños: P/T en menores de 5 años e IMC/E de 5 a 19 años según DE. Interpretar en conjunto, ningún parámetro aislado basta.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un hombre de 45 años mide 1,75 m y pesa 75 kg (IMC 24,5 kg/m²), pero su circunferencia de cintura es de 104 cm. Tiene una glicemia de ayuno alterada. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de su evaluación nutricional?**
> **A)** Estado nutricional normal, sin riesgo adicional
> **B)** Desnutrición leve
> **C)** IMC normal con obesidad abdominal, que implica mayor riesgo cardiometabólico
> **D)** Obesidad grado II
> **E)** La cintura no tiene valor si el IMC es normal
> Respuesta C. El IMC no distingue grasa de músculo ni su distribución. Una cintura sobre 102 cm en hombres (o sobre 90 cm con criterios para población latinoamericana) indica obesidad abdominal, con mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular aun con IMC normal. La evaluación nutricional del adulto incluye peso, talla, IMC y cintura.

1.02.4.013 Examen de orina completa

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Incluye examen físico-químico (densidad, pH, glucosa, proteínas, cetonas, nitritos, leucocitos, sangre) y sedimento (leucocitos, eritrocitos, cilindros, cristales, bacterias).
- ITU: piuria (>5–10 leucocitos/campo), bacterias y nitritos positivos; cilindros leucocitarios indican origen renal. Siempre confirmar con urocultivo.
- Glomerular: hematíes dismórficos y cilindros hemáticos (glomerulonefritis); proteinuria marcada y cuerpos grasos (síndrome nefrótico).
- Glucosuria aparece con glicemia >180 mg/dL (o con iSGLT2); cetonuria en CAD o ayuno.
- Muestra de segundo chorro, con aseo genital y procesada antes de 2 horas; la contaminación da células epiteliales abundantes.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un hombre de 30 años presenta orina color 'coca-cola' y edema palpebral 2 semanas después de una faringitis. Su presión arterial es 150/95 mmHg. **¿Qué hallazgo en el examen de orina completa confirma el origen glomerular de la hematuria?**
> **A)** Cristales de oxalato de calcio
> **B)** Leucocitos abundantes con bacterias
> **C)** Nitritos positivos
> **D)** Cilindros hemáticos y glóbulos rojos dismórficos
> **E)** Hematuria con coágulos
> Respuesta D. Los cilindros hemáticos y los glóbulos rojos dismórficos (acantocitos) indican sangrado de origen glomerular, aquí una probable glomerulonefritis postestreptocócica. La hematuria con coágulos sugiere origen urológico (vía urinaria), y nitritos con leucocitos y bacterias orientan a infección urinaria.

1.02.4.014 Examen de orina semicuantitativa

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Tira reactiva de lectura rápida: glucosa, cetonas, proteínas, sangre, leucocitos (esterasa), nitritos, pH y densidad.
- Nitritos positivos sugieren bacterias Gram negativas (E. coli); esterasa leucocitaria indica piuria. Tira negativa en ambos hace poco probable la ITU no complicada.
- Proteínas en tira detectan principalmente albúmina >300 mg/L; no sirve para tamizar albuminuria moderada (usar RAC).
- Sangre positiva sin hematíes en el sedimento: mioglobinuria o hemoglobinuria (rabdomiólisis, hemólisis).

- Es orientador: confirmar con sedimento, urocultivo o cuantificación según el hallazgo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Una mujer de 30 años consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 1 día. Refiere que orina cada 30 minutos. La tira reactiva de orina muestra leucocitos (+++) y nitritos negativos. **¿Cuál es la interpretación más adecuada del resultado de nitritos?**
>
> **A)** Descarta una infección urinaria
> **B)** Indica que la infección es viral
> **C)** Indica infección por E. coli
> **D)** Indica contaminación de la muestra
> **E)** Un nitrito negativo no descarta infección, porque requiere tiempo de permanencia de la orina en la vejiga y bacterias reductoras de nitratos
>
> Respuesta E. Los nitritos se forman cuando enterobacterias como E. coli reducen nitratos, lo que requiere unas 4 horas de orina en la vejiga. Con polaquiuria intensa o gérmenes no reductores (Enterococcus, S. saprophyticus) pueden ser negativos. Es específico pero poco sensible: un nitrito negativo no descarta ITU.

1.02.4.015 Glicemia capilar

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante · Tema 3.2 Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis · Tema 3.3 Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado · Tema 3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Herramienta de automonitoreo y de urgencia (hemoglucotest); no sirve para diagnosticar diabetes (usar glicemia venosa).
- Metas en DM2: preprandial 80–130 mg/dL y postprandial <180; en DMG ayuno 70–90/95, 1 h <140 y 2 h <120. Hospitalizados: 140–180.
- Frecuencia: DMG 4–6 veces/día; usuarios de insulina según esquema; el ayuno guía la titulación de la NPH nocturna (+2 UI si 131–180, +4 UI si >180).
- Hiperglicemia matinal: medir a las 3 AM; <70 = Somogyi (bajar la basal), >100 = fenómeno del alba (subir o retrasar la basal).
- Técnica: manos limpias y secas, punción lateral del pulpejo, primera gota válida si la piel está limpia; error en hipoperfusión, anemia o hematocrito extremo.

PREGUNTAS (4)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 78**
>
> Un paciente de 57 años, diabético desde hace 15 años, en tratamiento con metformina 1 gramo cada 12 horas e insulina NPH nocturna 10 UI por vía subcutánea. Respecto al control con glicemias capilares, **¿cuál es el esquema de control más adecuado?**
>
> **A)** Controlar dos horas después del desayuno
> **B)** Controlar dos horas después del almuerzo
> **C)** Controlar a primera hora en la mañana, en ayunas
> **D)** Controlar antes de cada comida
> **E)** Controlar antes de la administración de la insulina NPH nocturna
>
> Respuesta C. En el esquema basal con NPH nocturna, la glicemia que refleja esa insulina y guía su titulación es la de ayuno, a primera hora de la mañana.

Pregunta de práctica

Gestante de 30 semanas con diabetes gestacional, en plan de alimentación hace 2 semanas. Trae su registro de hemoglucotest: glicemias de ayuno entre 98 y 108 mg/dL en 6 de 14 mediciones; glicemias 1 hora postprandiales entre 112 y 132 mg/dL en todas las mediciones. Ecografía con circunferencia abdominal fetal en percentil 60. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener la dieta, ya que los postprandiales están en meta
B) Iniciar insulina NPH nocturna
C) Iniciar insulina rápida antes de cada comida
D) Iniciar glibenclamida en la mañana
E) Aumentar la frecuencia de hemoglucotest y reevaluar en un mes

Respuesta B. Metas de glicemia capilar en la diabetes gestacional: ayuno bajo 90–95 mg/dL y 1 hora postprandial bajo 140 mg/dL. Aquí el 43 % de los ayunos está fuera de meta (más del 20 %) y los postprandiales están bien: se indica insulina NPH nocturna, que corrige el ayuno.

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, DM2 en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas. Cursa el segundo día postoperatorio de una colecistectomía, hemodinámicamente estable y tolerando régimen oral completo. Ha tenido glicemias capilares entre 220 y 260 mg/dL. Pesa 80 kg y su función renal es normal. **¿Cuál es el manejo más adecuado de su diabetes durante la hospitalización?**

A) Reiniciar glibenclamida a la misma dosis
B) Insulina cristalina según hemoglucotest cada 6 horas como única terapia
C) Insulina basal más bolos prandiales de insulina rápida y escala de corrección
D) Infusión endovenosa continua de insulina cristalina
E) Observar sin tratamiento hasta que la glicemia supere 300 mg/dL

Respuesta C. Paciente no crítico que tolera alimentación: esquema basal-bolo-corrección subcutáneo, con meta de 140–180 mg/dL. La glibenclamida se suspende al ingreso por riesgo de hipoglicemia prolongada; el esquema móvil aislado está proscrito; la infusión EV se reserva para el paciente crítico.

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años, sin diabetes ni otros antecedentes, consulta por episodios de temblor, sudoración y palpitaciones 2 a 3 horas después de comer, que ceden al ingerir alimentos. Trae un registro de un glucómetro prestado con valores de 58, 62 y 64 mg/dL durante los síntomas. Examen físico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar una hipoglicemia?**

A) Diagnosticar hipoglicemia reactiva con el registro del glucómetro
B) Iniciar dieta fraccionada sin más estudio
C) Documentar una glicemia plasmática venosa baja durante los síntomas, que se corrijan al normalizarla
D) Solicitar hemoglobina glicosilada
E) Solicitar insulinemia basal de ayuno

Respuesta C. En una persona sin diabetes, la hipoglicemia se confirma con la tríada de Whipple usando glicemia plasmática (bajo 55 mg/dL), no con glucómetro, que es impreciso en rangos bajos. La glicemia capilar sirve para el automonitoreo y la urgencia del diabético, no para diagnosticar hipoglicemia en un no diabético.

1.02.4.016 Glicemia venosa

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

QUÉ HAY QUE SABER

- Plasmática venosa con 8 h de ayuno: <100 normal; 100–125 glicemia de ayuno alterada (pedir PTGO); ≥126 diabetes si se confirma en otro día.
- Glicemia al azar ≥200 mg/dL con síntomas (poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso) confirma diabetes sin repetir.
- Tamizaje en APS a quien tenga IMC ≥25 + 1 factor de riesgo o ≥45 años; normal: repetir en 3 años.
- Primera ≥126 y segunda <126 (discordante): PTGO para definir.
- En el embarazo los cortes bajan: ayuno ≥100 en dos ocasiones = DMG; en el hospitalizado el estrés la eleva (usar HbA1c).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 52 años, asintomático, se realiza en un examen preventivo una glicemia venosa de ayuno, que resulta 132 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir la glicemia venosa de ayuno otro día para confirmar
B) Diagnosticar diabetes e iniciar insulina
C) Diagnosticar prediabetes
D) Solicitar una glicemia capilar para confirmar
E) Descartar diabetes por estar asintomático

Respuesta A. El diagnóstico de diabetes requiere glicemia venosa de ayuno ≥126 mg/dL en 2 ocasiones en días distintos, o glicemia al azar ≥200 mg/dL con síntomas, o PTGO a las 2 horas ≥200 mg/dL. En un asintomático con un solo valor alterado se confirma repitiendo la glicemia venosa. La glicemia capilar no sirve para diagnosticar.

1.02.4.017 Hemoglobina glicosilada

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS · Tema 1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas · Tema 2.1 Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Refleja la glicemia promedio de los últimos 2–3 meses; se usa para diagnóstico (≥6,5 % en laboratorio estandarizado, confirmar en asintomático) y control.
- Prediabetes 5,7–6,4 %. Metas: <7 % estándar, <6,5 % joven sin riesgo de hipoglicemia, <7,5 % adulto mayor activo, <8–8,5 % frágil.
- Control cada 3 meses si está fuera de meta o se cambió el tratamiento; cada 6 meses si está estable en meta.
- Examen de elección en el hospitalizado o con corticoides: ≥6,5 % indica diabetes previa.
- Falsamente baja en hemólisis, hemorragia aguda, hemodiálisis o embarazo; falsamente alta en ferropenia prolongada y esplenectomía. La fructosamina refleja 2–3 semanas.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 106

Un paciente de 66 años es hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad. En su hemoglucotest de ingreso, se constata una glicemia capilar de 256 mg/dl. **¿Cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico de diabetes?**

A) Glicemia de ayuno > 126 mg/dl
B) Prueba de tolerancia a la glucosa > 200 mg/dl, postcarga de glucosa
C) Hemoglobina glicosilada > 6,5%
D) Prueba HOMA > 2,6
E) Albuminuria/creatininuria > 0,3

Respuesta C. En un paciente con enfermedad aguda, la glicemia y la PTGO se alteran por el estrés. La HbA1c refleja los 2–3 meses previos y no se modifica por la neumonía, por eso es el examen que confirma la diabetes en el hospitalizado.

Pregunta de práctica

Mujer de 52 años con DM2 de 3 años de evolución, en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas. Antecedente de mioma uterino con metrorragia abundante, por lo que recibió 2 unidades de glóbulos rojos hace 3 semanas. Trae HbA1c de 6,1 %, pero su registro de glicemias capilares de ayuno muestra valores entre 180 y 220 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Está en meta; mantener el tratamiento
B) La HbA1c está falsamente baja por la transfusión y la pérdida de sangre
C) El glucómetro está mal calibrado; confiar en la HbA1c
D) Debe reducirse la metformina por riesgo de hipoglicemia
E) La HbA1c está falsamente alta por la anemia ferropénica

Respuesta B. La HbA1c refleja la glucosa unida a la hemoglobina durante la vida del glóbulo rojo. La hemorragia y la transfusión reciente renuevan los eritrocitos y la bajan falsamente. Aquí manda el registro de glicemias capilares; se repite la HbA1c en 2–3 meses.

Pregunta de práctica

Mujer de 49 años con DM2 recién diagnosticada, HbA1c inicial 7,8 %. Asintomática, sin baja de peso. Se indica plan de alimentación, actividad física y metformina 850 mg cada 12 horas. Tolera bien el tratamiento y pregunta cuándo debe volver a medirse la HbA1c para saber si el tratamiento funcionó. **¿Cuándo corresponde controlar la HbA1c para evaluar la respuesta?**

A) A las 2 semanas
B) Al mes
C) A los 12 meses
D) A los 3 meses
E) No es necesario; basta con la glicemia de ayuno

Respuesta D. La HbA1c refleja el promedio glicémico de los 2–3 meses previos, que es la vida media útil del glóbulo rojo. Medirla antes no muestra el efecto real del cambio de tratamiento. Se controla a los 3 meses y, si no está en meta, se intensifica.

1.02.4.018 Insulinemia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Se interpreta junto a la glicemia de ayuno: HOMA-IR = glicemia × insulina / 405; >2,6 indica resistencia a la insulina (no es diabetes ni prediabetes).
- Resistencia con glicemia normal: estilo de vida (dieta y ejercicio), no metformina de rutina.
- Hipoglicemia en no diabético: muestra crítica con glicemia <55 mg/dL midiendo insulina, péptido C, proinsulina y sulfonilureas.
- Insulina alta + péptido C indetectable: insulina exógena (facticia); insulina y péptido C altos con screening de sulfonilureas negativo: insulinoma.
- No es examen de rutina para diagnosticar diabetes ni para el control; su uso aislado tiene poca utilidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 72

Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida 15 mg/día, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes desde hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de ayuno de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. **¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?**

A) Hipomagnesemia
B) Hipernatremia
C) Hipoglicemia
D) Hipocalcemia
E) Cetoacidosis

Respuesta C. Adulto mayor con glibenclamida: la causa más común de hipoglicemia severa. Las convulsiones son un síntoma neuroglucopénico. Una glicemia alta hace 3 días no descarta que hoy esté baja; los electrolitos normales alejan las otras causas.

1.02.4.019 Microalbuminuria

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Albuminuria moderada: 30–300 mg/24 h, o RAC 30–299 mg/g en muestra matinal (método preferido actual).
- Primer signo detectable de nefropatía diabética y marcador de riesgo cardiovascular.
- Tamizaje anual: DM2 desde el diagnóstico, DM1 a los 5 años del debut, y en hipertensos.
- Confirmar con 2 de 3 muestras en 3–6 meses; descartar ITU, fiebre, ejercicio intenso, IC descompensada o hiperglicemia grave.
- Confirmada: IECA o ARA-II aunque sea normotenso (nunca ambos) + iSGLT2, control estricto de PA y glicemia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 55 años con DM2 de 6 años, sin síntomas urinarios ni ejercicio intenso reciente, tiene en su control una relación albúmina/creatinina urinaria (RAC) de 85 mg/g, con VFG estimada de 80 mL/min/1,73 m². Es la primera vez que resulta alterada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Diagnosticar nefropatía diabética e iniciar diálisis
B) Confirmar repitiendo la RAC: se requieren 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses
C) Solicitar biopsia renal
D) Descartar el hallazgo porque la VFG es normal
E) Solicitar solo una ecografía renal

Respuesta B. Una RAC de 30 a 300 mg/g es albuminuria moderadamente elevada (antes 'microalbuminuria'), marcador precoz de nefropatía diabética y de riesgo cardiovascular. Por su variabilidad (ejercicio, fiebre, ITU, descompensación) se confirma con 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses. Confirmada, se indica IECA o ARA II y se considera iSGLT2.

1.02.4.020 Nitrogeno urinario

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Nitrógeno ureico urinario de 24 horas: estima el catabolismo proteico y permite calcular el balance nitrogenado.
- Balance nitrogenado = (proteínas ingeridas en g / 6,25) – (NUU + 4 g de pérdidas no urinarias).
- Balance negativo: catabolismo (sepsis, trauma, quemados, cirugía mayor, aporte insuficiente); positivo: anabolismo, objetivo del soporte nutricional.
- Requiere recolección completa de orina de 24 h y función renal relativamente conservada; se altera en ERC, diarrea o fístulas.
- Se usa en pacientes hospitalizados con soporte nutricional para ajustar el aporte proteico (habitualmente 1,2–2 g/kg/día en catabólicos).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un paciente de 40 años, en UCI por politraumatismo, recibe nutrición enteral con 75 g de proteínas al día (12 g de nitrógeno). Para evaluar si el aporte proteico es suficiente, se mide el nitrógeno ureico urinario de 24 horas: 18 g/día. **¿Cuál es la interpretación del balance nitrogenado?**

A) Balance positivo: está en anabolismo
B) Balance neutro
C) Balance negativo de unos 10 g/día: hipercatabolismo con aporte proteico insuficiente
D) El nitrógeno urinario no sirve para evaluar el estado nutricional
E) Indica insuficiencia renal aguda

Respuesta C. Balance nitrogenado = nitrógeno aportado (proteínas / 6,25) – (nitrógeno ureico urinario + 4 g de pérdidas no urinarias). Aquí: 12 – (18 + 4) = –10 g/día. Un balance negativo indica catabolismo proteico mayor que el aporte, típico del trauma y la sepsis, y obliga a aumentar el aporte proteico.

1.02.4.021 Perfil lipídico

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Incluye colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL (Friedewald: CT – HDL – TG/5, válido si TG <400); ayuno de 9–12 h, sobre todo para TG.
- Meta según riesgo cardiovascular: LDL <55–70 riesgo muy alto, <70 alto, <100 moderado; HDL bajo <40 hombre y <50 mujer; TG normal <150.
- LDL ≥190 con TG normales: sospechar hipercolesterolemia familiar. TG ≥500: prioridad prevenir pancreatitis (fibrato).
- Control a las 6–12 semanas de iniciar o cambiar estatina y luego anual si está en meta.
- Descartar causas secundarias: hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, diabetes descompensada, alcohol, fármacos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con obesidad y consumo diario de alcohol, en control de salud. Perfil lipídico en ayunas de 12 horas: colesterol total 260 mg/dL, HDL 34 mg/dL, triglicéridos 520 mg/dL. El informe del laboratorio no entrega el valor de LDL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada respecto al colesterol LDL?**

A) Calcular el LDL con la fórmula de Friedewald: 122 mg/dL
B) El LDL no tiene importancia en este paciente
C) Repetir el perfil sin ayuno para obtener el LDL
D) El LDL es igual al colesterol total menos el HDL
E) Con triglicéridos sobre 400 mg/dL la fórmula de Friedewald no es válida; se usa LDL medido en forma directa o el colesterol no HDL

Respuesta E. La fórmula de Friedewald (LDL = colesterol total – HDL – triglicéridos/5) solo es válida con triglicéridos bajo 400 mg/dL. Sobre ese valor sobreestima las VLDL y subestima el LDL. Se pide LDL directo o se usa el colesterol no HDL (aquí 226 mg/dL). Además, con triglicéridos sobre 500 la prioridad es prevenir la pancreatitis.

1.02.4.022 Proteiuniria 24 horas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Normal <150 mg/24 h; rango nefrótico >3,5 g/24 h (con albúmina <3 g/dL, edema y dislipidemia = síndrome nefrótico).
- Alternativa más práctica: índice proteinuria/creatininuria en muestra aislada (>3–3,5 equivale a rango nefrótico; ≥0,2 mg/mg es marcador de daño renal).
- Verificar recolección adecuada con la creatininuria de 24 h (aprox. 15–25 mg/kg/día).
- Útil para cuantificar proteinuria en glomerulopatías, preeclampsia (≥300 mg/24 h) y seguir la respuesta al tratamiento.
- En el diabético el tamizaje se hace con RAC, no con orina de 24 h.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 35 años presenta edema progresivo de extremidades inferiores y palpebral de 3 semanas. Tiene orina espumosa, albúmina plasmática de 2,1 g/dL y colesterol total de 340 mg/dL. El sedimento urinario no muestra cilindros hemáticos. **¿Qué resultado de proteinuria de 24 horas confirma el síndrome nefrótico?**

A) Mayor de 3,5 g/24 h
B) 500 mg/24 h
C) 1,5 g/24 h
D) 150 mg/24 h
E) Proteinuria negativa

Respuesta A. El síndrome nefrótico del adulto se define por proteinuria mayor de 3,5 g/24 horas, hipoalbuminemia bajo 3 g/dL, edema y dislipidemia. La proteinuria normal es menor de 150 mg/24 horas. Una alternativa práctica es el índice proteína/creatinina en orina aislada mayor de 3 a 3,5 g/g.

1.02.4.023 Test de esfuerzo

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba de ejercicio en cinta con ECG y PA continuos; evalúa isquemia inducible, capacidad funcional y respuesta presora.
- En el diabético no se pide de rutina antes de iniciar ejercicio moderado; se considera antes de ejercicio vigoroso en sedentarios con alto riesgo cardiovascular, síntomas o ECG basal alterado.
- Positivo: infradesnivel del ST ≥1 mm horizontal o descendente, angina, caída de la PA o arritmias; indica derivar a cardiología.
- Contraindicaciones: SCA reciente, estenosis aórtica severa sintomática, IC descompensada, arritmias no controladas; ECG basal no interpretable (BCRI, marcapasos) requiere test con imagen.

- El médico general emplea el informe para prescribir la intensidad del ejercicio y derivar si es positivo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 58 años, diabético e hipertenso, refiere desde hace 2 meses opresión retroesternal al subir 2 pisos de escalera, que cede en 3 minutos con el reposo. Su ECG de reposo es normal y puede caminar sin limitaciones ortopédicas. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado para el estudio de isquemia?**

A) Coronariografía de urgencia
B) Test de esfuerzo (ergometría)
C) Holter de ritmo
D) Troponinas seriadas en urgencia
E) Ecocardiograma transesofágico

Respuesta B. Es una angina estable: de esfuerzo, cede con el reposo y su patrón no ha cambiado en 2 meses. Si el paciente puede ejercitarse y su ECG basal es interpretable, el test de esfuerzo es el examen inicial no invasivo para detectar isquemia y estratificar riesgo. Si no, se usan pruebas con imagen.

1.02.4.024 Test de tolerancia a la glucosa

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS · Tema 1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)

QUÉ HAY QUE SABER

- PTGO: glicemia basal y a las 2 h tras 75 g de glucosa, con 3 días de dieta normal previa y ayuno de 8 h.
- No embarazada: 2 h <140 normal; 140–199 intolerancia a la glucosa; ≥200 diabetes.
- Indicación: glicemia de ayuno 100–125 o resultado discordante (primera ≥126 y segunda <126). No pedir si ya hay criterio diagnóstico de diabetes.
- Embarazada: universal a las 24–28 semanas; basal ≥100 o 2 h ≥140 = DMG (basta un valor). Repetir a las 32–34 sem en alto riesgo; PTGO a las 6–12 semanas posparto.
- No es válida durante enfermedad aguda o con corticoides (usar HbA1c).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 158

Mujer asintomática de 46 años de edad, con IMC de 24. Tiene antecedente de diabetes gestacional con su último embarazo. Se practica una glicemia en ayunas que resulta en 112 mg/dl. **La conducta más adecuada es:**

A) Repetir la glicemia en ayunas
B) Practicar niveles de hemoglobina glicosilada
C) Indicar metformina
D) Realizar control de glicemia en 6 meses
E) Solicitar curva de tolerancia a la glucosa

Respuesta E. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL en una mujer no embarazada: glicemia de ayuno alterada. La conducta es la PTGO con 75 g; repetir la glicemia de ayuno no aporta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 95

Un paciente de 39 años, con antecedente de obesidad, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, que muestra una glicemia basal de 117 mg/dl y postcarga de 75 gramos de glucosa de 136 mg/dl. **El diagnóstico más probable es:**

A) Normal
B) Diabetes mellitus 2
C) Intolerancia a la glucosa oral
D) Diabetes mellitus 1
E) Prediabetes

Respuesta E. Basal 117 mg/dL: glicemia de ayuno alterada. Postcarga 136 mg/dL (< 140): sin intolerancia ni diabetes. La GAA es una forma de prediabetes.

Pregunta de práctica

Embarazada de 33 años, multípara de 2, cursando 32 semanas. Glicemia de ayuno de ingreso 84 mg/dL. PTGO con 75 g a las 26 semanas: 82 mg/dL basal y 128 mg/dL a las 2 horas. En la ecografía actual el feto está en percentil 95 de peso y el ILA es de 26 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir la PTGO con 75 g ahora
B) Mantener control prenatal habitual
C) Iniciar insulina NPH nocturna
D) Solicitar hemoglobina glicosilada
E) Solicitar glicemia de ayuno cada 2 semanas

Respuesta A. La PTGO de las 24–28 semanas fue normal, pero aparecen factores de alto riesgo: feto grande y polihidramnios. En ese caso se repite la PTGO entre las 32 y 34 semanas para no pasar por alto una diabetes gestacional tardía. Sin diagnóstico no corresponde iniciar insulina.

1.02.4.025 Urocultivo y antibiograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico de ITU: ≥100.000 UFC/mL en orina de segundo chorro (menos en sondeo o punción); tomar siempre antes del antibiótico en ITU complicada, pielonefritis, embarazo y recurrencias.
- Bacteriuria asintomática: solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos; no tratar en diabéticos ni ancianos.
- Agente más frecuente: E. coli. El antibiograma guía el ajuste del tratamiento empírico; buscar BLEE en hospitalizados o con uso previo de antibióticos.
- Pielonefritis ambulatoria: control a las 48–72 h revisando respuesta y cultivo; hospitalizar en embarazo, intolerancia oral, sepsis, obstrucción o DM descompensada.
- Contaminación: varios gérmenes o recuentos bajos con células epiteliales; repetir con buena técnica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 62 años, diabética, presenta fiebre de 39 °C, calofríos, dolor lumbar derecho y puño percusión positiva. Está hemodinámicamente estable. Hace 3 meses recibió ciprofloxacino por una cistitis. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del urocultivo?**

A) Iniciar antibiótico sin solicitar urocultivo
B) Solicitar urocultivo solo si no responde en 1 semana
C) Esperar el resultado del urocultivo (48 a 72 horas) para iniciar antibiótico
D) Tomar urocultivo con antibiograma antes de iniciar el antibiótico empírico, y ajustar según el resultado
E) Usar la orina recolectada el día anterior

Respuesta D. En una pielonefritis, especialmente en diabéticos o con uso reciente de antibióticos, se toma urocultivo con antibiograma (segundo chorro, previo aseo) antes del primer antibiótico, sin retrasar el tratamiento empírico. El antibiograma permite ajustar ante resistencia, frecuente a quinolonas en Chile. Esperar el resultado para tratar es peligroso.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 3 códigos

1.02.5.001 Curaciones básicas del pié diabético

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicada en úlceras Wagner 0–2 de manejo ambulatorio; Wagner 3–5 (absceso, osteomielitis, gangrena) se hospitalizan.
- Técnica: lavado con suero fisiológico a presión, retiro de esfacelo, tejido necrótico e hiperqueratosis (desbridamiento), y apósito que mantenga un ambiente húmedo fisiológico (curación avanzada).
- Evitar antisépticos citotóxicos y pomadas; no hisopar la superficie para cultivo (tomar tejido profundo).

- Descarga de presión obligatoria (reposo, férula de contacto total, calzado especial): sin descarga ninguna úlcera cicatriza.
- Evaluar en cada curación signos de infección (celulitis, secreción, mal olor), profundidad con estilete (si toca hueso: osteomielitis) y pulsos; derivar si empeora o hay isquemia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 66 años con DM2 y polineuropatía. Úlcera plantar de 1,5 cm bajo la cabeza del 2.º metatarsiano, superficial, con bordes de hiperqueratosis y fondo con algo de tejido esfacelado. Sin eritema, calor ni secreción purulenta; estilete óseo negativo. Pulsos pedios presentes. **¿Cuál es el manejo local más adecuado de la úlcera?**

A) Lavado con povidona yodada y agua oxigenada, y gasa seca
B) Antibiótico tópico y dejar la úlcera expuesta al aire
C) Lavado con suero fisiológico, desbridamiento del esfacelo y la hiperqueratosis, apósito que mantenga un ambiente húmedo y descarga de la zona
D) Cefadroxilo oral por 14 días y reposo
E) Hospitalizar para desbridamiento quirúrgico

Respuesta C. Úlcera neuropática Wagner 1 sin infección: manejo ambulatorio con curación avanzada. Se lava con suero fisiológico, se retira el tejido desvitalizado y la callosidad, se usa un apósito que mantenga un ambiente húmedo fisiológico y se descarga la zona. Los antisépticos dañan el tejido de granulación y sin infección no se indican antibióticos.

1.02.5.002 Evaluacion nutricional subjetiva

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración global subjetiva (VGS): método clínico simple, validado, basado en historia y examen físico, sin exámenes de laboratorio.
- Historia: cambio de peso en 6 meses y últimas 2 semanas, cambios en la ingesta, síntomas gastrointestinales (>2 semanas), capacidad funcional y demanda metabólica de la enfermedad.
- Examen: pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax), atrofia muscular (cuádriceps, deltoides, temporal), edema de tobillos o sacro y ascitis.
- Clasifica en A (bien nutrido), B (desnutrición moderada o en riesgo) y C (desnutrición severa).
- B o C: indicar intervención nutricional y derivar a nutricionista; útil antes de cirugías mayores y al ingreso hospitalario.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 66 años será operado de un cáncer gástrico. En la evaluación nutricional subjetiva global refiere baja de peso de 12% en 6 meses, ingesta reducida a la mitad hace 1 mes, náuseas frecuentes y capacidad funcional disminuida; al examen tiene pérdida de grasa subcutánea y de masa muscular temporal. **¿Cómo se clasifica según la evaluación subjetiva global y qué implica?**

A) A (bien nutrido): operar sin intervención nutricional
B) B (moderadamente desnutrido): no requiere intervención
C) Requiere exámenes de laboratorio para poder clasificarlo
D) No es aplicable en pacientes oncológicos
E) C (severamente desnutrido): iniciar soporte nutricional preoperatorio

Respuesta E. La evaluación subjetiva global es clínica (anamnesis y examen), sin exámenes: considera cambio de peso, ingesta, síntomas digestivos, capacidad funcional, estrés metabólico y signos físicos. Una baja sobre 10% en 6 meses con pérdida de grasa y músculo clasifica como C, desnutrición severa, y justifica soporte nutricional preoperatorio por 7 a 14 días.

1.02.5.003 Fondo de ojo

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: oftalmoscopio directo en sala oscura, idealmente con pupila dilatada (tropicamida); comenzar con el rojo pupilar, luego papila, vasos, mácula y periferia.
- Contraindicación de midriasis: cámara anterior estrecha (riesgo de glaucoma agudo); evitar en pacientes con lesión neurológica en observación.
- Diabetes: microaneurismas (lesión más precoz), hemorragias, exudados duros y algodonosos; neovasos = proliferativa, derivar urgente.
- Hipertensión: estrechamiento arteriolar, cruces arteriovenosos, hemorragias en llama; edema de papila en emergencia hipertensiva o HTEC.
- Rojo pupilar ausente con pérdida visual súbita indolora: hemorragia vítrea. En APS el tamizaje se hace con retinografía no midriática anual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Joven de 19 años con DM1 diagnosticada a los 16 años, en esquema basal-bolo, HbA1c 7,4 %. Nunca se ha realizado un fondo de ojo. Su padre, DM2 diagnosticado la semana pasada a los 50 años, también consulta. Ninguno refiere síntomas visuales. **¿Cuándo corresponde realizar el primer fondo de ojo de tamizaje a cada uno?**

A) Ambos de inmediato
B) Al hijo de inmediato y al padre en 5 años
C) Al hijo a los 30 años y al padre a los 5 años del diagnóstico
D) Ambos solo si presentan síntomas visuales
E) Al hijo a los 5 años del debut, es decir a los 21 años, y al padre de inmediato

Respuesta E. En la DM2 el fondo de ojo se realiza al momento del diagnóstico, porque la enfermedad pudo llevar años sin detectarse, y luego cada año. En la DM1 el tamizaje parte a los 5 años del debut, ya que la retinopatía no aparece antes. La retinopatía es silenciosa: se busca, no se espera a los síntomas.